Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje del consumo de alcohol en la familia en el entorno hogar

Gobernación de Boyacá | Salud

Gloria Yaneth Manrique Abril

Secretaria de salud

Candy Samanta Rodríguez Castillo

Directora de Promoción y Prevención

Martín Orlando Barrera Cobos

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Blanca Nubia Vásquez

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Grupo Desarrollador

Lorena Mesa Melgarejo

Enfermera, Magister en Salud Pública, Máster en Economía de la Salud y Doctora en Salud Pública. Secretaria de Salud de Boyacá

Oscar Alejandro Marín

Psicólogo. Especialista en Desarrollo Humano y promoción de la salud. Consultor.

Jaime Alberto Osorio Bedoya

Médico familiar. Docente programa de especialización en medicina familia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Martin Orlando Barrera Cobos

Enfermero. Enfermero especialista en enfermería en salud mental. Profesional universitario Secretaría Salud de Boyacá.

Expertas y expertos participantes

Andrés Felipe Calvo Abaunza

Psicólogo. Magíster en Drogodependencias. Docente programa de Psicología. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Angela Marcela Cujaban Montaña

Psicóloga. Especialista en gestión pública. Profesional especializado. Referente del Programa de convivencia social y salud mental de Secretaria de Salud de Boyacá.

Orlando Torres Cabra

Psicólogo. Especialista en adicciones. Profesional de apoyo. Equipo del Programa de convivencia social y salud mental de Secretaria de Salud de Boyacá.

Declaración de conflictos de intereses:

Las personas que participaron en la elaboración, revisión y validación de las presentes Pautas de cuidado basadas en la evidencia fueron invitadas a declarar sus intereses financieros, profesionales, académicos, institucionales y personales que pudieran influir, o percibirse como susceptibles de influir, en el desarrollo de los contenidos y la formulación de las recomendaciones. No se identificaron conflictos de intereses que comprometieran la independencia técnica del proceso de elaboración de este documento.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial:

La herramienta Claude de Anthropic fue utilizada en el presente documento para el proceso de extracción de datos de los textos completos seleccionados en las matrices de síntesis de la información. Su utilización fue complementaria al trabajo del equipo responsable y no sustituyó los procedimientos de búsqueda, selección, análisis crítico e interpretación de la evidencia científica, ni los procesos de deliberación y formulación de las pautas de cuidado. La responsabilidad por la rigurosidad metodológica, la pertinencia de las recomendaciones, la integridad de la información y el contenido final del documento corresponde exclusivamente al equipo humano responsable de su elaboración

Contenido

1. Introducción 7
2. Objetivos 9
2.1 General 9
2.2 Específicos 9
3. Alcance 9
Población objetivo 9
Usuarios 9
Contexto 9
Aspectos abordados 10
Aspectos no abordados 10
4. Contexto territorial de la condición de salud 10
5. Marco normativo 11
6. Preguntas orientadoras 13
7. Metodología 14
Metodología 14
7.1 Priorización de temas 14
7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras. 15
7.3 Búsqueda y selección de la evidencia. 15
7.1 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia. 17
7.2 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión. 17
8. Resultados 17
8.1 Marco global para el abordaje de los riesgos y daños relacionados con el alcohol 17
8.2 Síntesis narrativa de la evidencia 20
8.2.1 Pregunta 1 20
8.2.2 Pregunta 2 27
8.2.3 Pregunta 3 34
8.2.4 Pregunta 4 40
9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje de los riesgos y daños en las familias con consumo de alcohol en alguno de sus miembros en el entorno hogar. 48

9.1 Pautas generales 49
9.2 Pautas pregunta 1. Valoración inicial 51
9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones 55
9.4 Pautas pregunta 3. Canalización prioritaria 58
9.5 Pautas pregunta 4 61
10. Referencias 64
11. Anexos 71
11.1 Ecuaciones de búsqueda 71

1. Introducción

El consumo de alcohol constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial (1). Se trata de un producto tóxico y psicoactivo, clasificado como carcinógeno del Grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer desde 1988 (2) , cuyo consumo desempeña un papel causal en más de 200 enfermedades, lesiones y otras condiciones de salud (1). Entre estas se incluyen al menos siete tipos de cáncer como cavidad oral, faringe, laringe, esófago, mama (en mujeres), hígado y colon-recto (2), así como diversos trastornos de salud mental. La comorbilidad entre el trastorno por consumo de alcohol y cuadros como la depresión y la ansiedad ha sido ampliamente documentada, con estimaciones que duplican el riesgo de presentar uno de estos trastornos en presencia del otro (3). Sus daños, sin embargo, no se circunscriben a la salud física y mental: el consumo de alcohol se asocia también con diferentes formas de violencia, incluidas la violencia de pareja y la agresión sexual, con siniestros viales y otros accidentes, y con la privación económica de los hogares, lo que afecta tanto el desarrollo individual como el colectivo (1). Se estima, además, que el consumo de alcohol constituye una barrera para el logro de al menos 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, al obstaculizar metas vinculadas a la salud, la igualdad de género, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, entre otras (4,5).

En consecuencia, resulta urgente avanzar en el desarrollo de políticas y acciones basadas en evidencia que contribuyan a transformar los contextos, como el familiar, que pueden fomentar y favorecer el consumo de alcohol y, con ello, los daños asociados. La evidencia disponible muestra que las prácticas parentales relacionadas con el alcohol, la exposición al consumo de los progenitores y la mayor permisividad familiar frente a la bebida se asocian de manera consistente con un mayor riesgo de consumo en hijos e hijas(6), lo que subraya la importancia de intervenir tempranamente sobre la dinámica familiar como estrategia de prevención.

En Boyacá, el consumo de alcohol en el contexto familiar constituye un problema prioritario por su alta frecuencia, su relación con daños clínicos y sociales, y su capacidad de amplificar otros riesgos en el hogar (violencias, conflictos, problemas de salud mental y deserción escolar). El ASIS 2024 identifica que el consumo problemático de alcohol y otras sustancias es una de las situaciones más reportadas dentro de la categoría de salud mental por los municipios, donde 100 de 123 municipios refieren problemas relacionados con salud mental (incluida violencia), y entre las situaciones más comunes que las detonan se incluye explícitamente el

consumo problemático de alcohol (7). Este fenómeno se enmarca en una percepción comunitaria de bajo riesgo, aunque son reconocidos sus en impactos familiares, como violencia intrafamiliar y de género, deterioro de la salud mental y sobrecarga del sistema de salud.

Desde el Plan Integral de Cuidado Familiar (PICF) y su sistema de información (SIBACOM), el problema aparece como un riesgo identificable y priorizable en el entorno hogar. Durante los ejercicios de priorización con referentes de la Secretaria de Salud y con base en los datos del ASIS, PCIF y Plan territorial departamental de salud, se identifican prevalencias importantes de consumo problemático de alcohol en algunas subredes (por ejemplo, Subred 2: 52,2%; Subred 3: ~10,7%), lo que sugiere heterogeneidad territorial y necesidad de estandarización de la respuesta y acompañamiento desde equipos básicos. Es importante reconocer que desde el PICF, ya se aborda el fenómeno a través de acciones como tamizaje, consejería breve, intervención familiar, reducción de daños y articulación con rutas de atención.

La revisión de Cochrane muestra que las intervenciones breves realizadas por profesionales en atención primaria pueden reducir el consumo perjudicial en población que no consulta específicamente por alcohol(8) . En la misma línea, la USPSTF recomienda tamizar el consumo no saludable en adultos (incluidas gestantes) y ofrecer intervenciones conductuales breves a quienes tamizan positivo, dada la evidencia de beneficio(9). Este tipo de intervenciones deben ser explicitadas y estandarizadas para favorecer el acompañamiento a los compromisos de la familia.

En este marco, el "abordaje a la familia con miembro con consumo de riesgo o problemático de alcohol en el entorno hogar" se justifica contar con una herramienta para reducir variabilidad y orientar decisiones consistentes en el PICF, que pueda abordar por ejemplo qué instrumento usar y cómo interpretarlo, cómo realizar intervención breve y acuerdos familiares de seguridad y cuidado, cómo manejar comorbilidades y riesgos asociados, y cuándo activar rutas y apoyos comunitarios. Esto permite que la visita en el entorno hogar pase de "identificar" el riesgo a explicitarlo en el plan familiar desde una perspectiva de acompañamiento para la reducción de daño y acceso oportuno a servicios.

2. Objetivos

2.1 General

Desarrollar orientaciones de cuidado con base en evidencia para soportar las acciones del equipo de salud en el entorno hogar que permitan identificar, estratificar y acompañar el logro de los compromisos de la familia entorno al consumo de alcohol y abordando los riesgos y daños asociados.

2.2 Específicos

- ✓ Definir y estandarizar, desde un enfoque familiar y sistémico en el entorno hogar, los criterios para ayudar a identificar y estratificar el consumo de alcohol en un integrante y el riesgo familiar asociado.
- ✓ Establecer las intervenciones basadas en evidencia y factibles en el entorno hogar para acompañar la decisión sobre el abordaje de los riesgos y daños por consumo de alcohol, con criterios de priorización según severidad y contexto del hogar.
- ✓ Precisar los criterios de alarma y activación de redes desde el entorno hogar y el nivel primario de acuerdo con la clasificación y priorización de riesgos, articulando respuestas de las redes.
- ✓ Identificar estrategias educativas y de información en salud basada en la evidencia que facilite el acompañamiento al compromiso de la persona y la familia frente a los riesgos y daños por consumo de alcohol.

3. Alcance

Población objetivo
Personas identificadas en la familia y el entorno hogar que consumen alcohol.

Usuarios
Equipos básicos de salud que realizan implementación del PICF.

Contexto
Entorno hogar (visita PICF) para educación, detección y acompañamiento al abordaje de los riesgos por consumo de alcohol en algún miembro de la familia.

Aspectos abordados

- Identificación y estratificación: tamizaje con instrumentos validados, evaluación clínica breve, valoración de riesgos familiares (violencia, seguridad, curso de vida, comorbilidad).
- Intervención integral: intervención breve y/o entrevista motivacional breve, consejería para reducción de riesgos y daños, acuerdos familiares (seguridad y corresponsabilidad), activación de redes de apoyo y derivación.
- Gestión del riesgo: plan de cuidado familiar, seguimiento, verificación de acceso efectivo, adherencia a acuerdos y continuidad del proceso.

Aspectos no abordados

- Protocolos detallados de desintoxicación hospitalaria, manejo farmacológico especializado del trastorno por uso de alcohol o comorbilidad psiquiátrica severa (se define cuándo remitir).
- Manejo clínico avanzado de complicaciones médicas graves asociadas al alcohol (cirrosis descompensada, pancreatitis aguda, etc.), salvo criterios de alarma y remisión.
- Intervenciones judiciales o de protección: se incluyen criterios de activación y articulación, pero no se reemplazan rutas legales vigentes.

4. Contexto territorial de la condición de salud

El consumo de alcohol es un determinante relevante de carga de enfermedad y de daños evitables a nivel familiar y comunitario. La OMS estima que, en 2019, el consumo de alcohol se asoció con ≈2,6 millones de muertes a nivel global, con una proporción importante atribuida a enfermedades no transmisibles y lesiones. En Boyacá, el ASIS 2024 (con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019) reporta que 70% de la población consumió alcohol en el último año, por encima del referente nacional (54,5%), lo cual sugiere una alta exposición poblacional al riesgo(7) . En el mismo documento, se reconoce que el consumo problemático de alcohol aparece de forma recurrente en los diagnósticos municipales de salud mental: 100 de 123 municipios refieren problemas en salud mental (incluida violencia), y dentro de las situaciones más frecuentes se incluye explícitamente el consumo problemático de alcohol.

Complementariamente, los insumos del PICF/SIBACOM (recogidos en el documento de priorización) muestran heterogeneidad territorial: el PICF

julio identifica prevalencias altas de consumo problemático en algunas subredes (por ejemplo, Subred 2: 52,2%; Subred 3: ~10,7%), lo que refuerza la necesidad de estandarizar la identificación, priorización y respuesta desde el entorno hogar(10).

Para el lineamiento, es útil diferenciar niveles de riesgo y gravedad. La OMS describe el alcohol como una sustancia psicoactiva y tóxica que puede causar dependencia y múltiples daños en salud. Operativamente, "consumo de riesgo" se refiere a patrones que aumentan la probabilidad de daño futuro (aunque aún no existan consecuencias evidentes), mientras que "consumo problemático" incluye consumo nocivo y/o posible trastorno por uso de alcohol, caracterizado por consecuencias en salud, funcionamiento o seguridad. En atención primaria, una herramienta central es el AUDIT(11), desarrollado por la OMS como un método sencillo para tamizaje de consumo excesivo y apoyo a una evaluación breve, incluyendo la identificación de consumo riesgoso, nocivo y probable dependencia. La evidencia apoya que, una vez identificado el consumo no saludable, las intervenciones breves en atención primaria pueden reducir el consumo en bebedores de riesgo o nocivos que no consultan buscando tratamiento por alcohol, lo cual es altamente pertinente para el abordaje proactivo en el entorno hogar del PICF(12).

En la familia, el alcohol no impacta solo a quien consume: aumenta riesgo de conflicto, violencia, negligencia de cuidados, accidentes, afectación económica, deterioro de la convivencia y problemas de salud mental en cohabitantes. El ASIS 2024 vincula explícitamente el consumo problemático con el panorama de salud mental municipal, en un contexto donde se reportan también violencias como parte del mismo entramado de riesgo social (7). Esta realidad exige un enfoque familiar y sistémico: identificar y manejar riesgos asociados (violencia, seguridad del hogar, curso de vida, comorbilidad psiquiátrica), proteger a niñas/niños y otros integrantes vulnerables, y transformar el abordaje en acuerdos familiares concretos (seguridad, corresponsabilidad, acceso a apoyo). Desde el PICF, la pertinencia es directa: el documento de priorización reconoce el consumo problemático como un tema de alta "accionabilidad" desde equipos básicos mediante tamizaje, consejería e intervención familiar, con articulación a rutas de atención cuando la severidad lo amerita.

5. Marco normativo

El desarrollo del presente documento tiene en consideración el marco normativo nacional y territorial vigente y en particular las siguientes normas aplicables:

Tabla 1. Normativa aplicable a la herramienta

Norma	**Aspecto**
Ordenanza 023 de 2010 del departamento de Boyacá	Establece el Modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar como política pública en el departamento de Boyacá, orientando la atención integral de las personas, familias y comunidades y la acción intersectorial sobre los determinantes de la salud.
Ley 124 de 1994	Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y establece medidas orientadas a prevenir su consumo y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados al alcohol.
Ley 1098 de 2006	Código de la Infancia y la Adolescencia. Establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser protegidos frente al consumo de tabaco, sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, así como frente a situaciones de violencia, abuso, negligencia y vulneración de derechos.
Decreto 120 de 2010	Adopta medidas relacionadas con el consumo de alcohol dirigidas a proteger a la población frente a sus efectos nocivos y a reducir los daños y riesgos asociados, incluida la accidentalidad, la violencia, la conducción bajo sus efectos y la exposición de niños, niñas y adolescentes.
Ley 1438 de 2011	Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y fortalece la Atención Primaria en Salud como estrategia para la atención integral e integrada, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la coordinación intersectorial.
Ley 1566 de 2012	Reconoce el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas como un asunto de salud pública y bienestar de la persona, la familia y la comunidad, y establece el derecho a la atención integral de las personas afectadas por estos consumos.
Ley 1616 de 2013 y sus modificaciones	Establece disposiciones para garantizar el ejercicio del derecho a la salud mental mediante acciones de promoción, prevención y atención integral. Constituye un marco para el abordaje de los problemas relacionados con el consumo de alcohol, las comorbilidades en salud mental y sus afectaciones familiares y sociales.
Ley 1696 de 2013	Establece disposiciones penales y administrativas para prevenir y sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas y fortalecer la prevención de lesiones, accidentes y muertes asociadas.
Ley 1751 de 2015	Regula el derecho fundamental a la salud y establece obligaciones relacionadas con la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reducción de las desigualdades en salud.
Resolución 3280 de 2018	Adopta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal. Incluye acciones de detección temprana de riesgos relacionados con el consumo

	de alcohol y otras sustancias y su articulación con las rutas de atención.
Resolución 4886 de 2018	Adopta la Política Nacional de Salud Mental, con énfasis en promoción, prevención, atención integral, curso de vida, determinantes sociales y entornos, e incorpora el consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias individuales, familiares y sociales dentro de las prioridades de salud mental.
Resolución 089 de 2019	Adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Orienta acciones de prevención, detección temprana, reducción de riesgos y daños, intervención breve, atención integral y articulación de respuestas individuales, familiares, comunitarias e intersectoriales.
Resolución 1035 de 2022, modificada por la Resolución 2367 de 2023	Adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y orienta la gestión de los determinantes sociales de la salud, la reducción de inequidades, la acción intersectorial y la adaptación territorial de las intervenciones de salud pública.
Ley 2297 de 2023	Establece medidas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y de sus cuidadores o asistentes personales. Resulta pertinente cuando los riesgos y daños relacionados con el consumo de alcohol comprometen responsabilidades de cuidado o la seguridad de personas dependientes.
Resolución 1597 de 2025	Establece disposiciones para la gestión territorial integral de la salud pública, incluida la Gestión en Salud Pública y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública y la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Fuente: elaboración propia

6. Preguntas orientadoras

- P1. En familias con uno o más integrantes que presentan consumo de alcohol asociado con riesgos o daños, ¿qué intervenciones familiares, domiciliarias o articuladas con la atención primaria son efectivas y factibles para prevenir, reducir o manejar los daños individuales, familiares y del entorno?
- P2. ¿Qué herramientas educativas, comunicativas, conductuales, participativas y de planificación pueden utilizarse en el entorno hogar para que las familias reconozcan y modifiquen prácticas cotidianas que incrementan los riesgos y daños relacionados con el consumo de alcohol?
- P3. ¿Qué signos, síntomas, comportamientos, situaciones familiares y condiciones del entorno asociados con el consumo de alcohol indican la necesidad de solicitar atención inmediata,

activar rutas de urgencias o protección, o gestionar una valoración prioritaria?

- P4. ¿Qué estrategias educativas, participativas, relacionales y de seguimiento fortalecen la agencia de cuidado de las familias para construir y sostener un entorno protector que no normalice ni facilite el consumo de alcohol, reduzca la exposición a sus riesgos y daños, favorezca prácticas cotidianas de cuidado y permita definir, implementar y monitorear compromisos familiares?

7. Metodología

Metodología

El desarrollo de esta herramienta se basa en el Manual para el desarrollo de lineamientos técnicos basados en evidencia del IETS (primera edición, 2024) y en el objetivo de consolidar y difundir acciones/indicaciones basadas en la mejor evidencia disponible e integrando experiencia experta y contexto territorial. Así, la metodología se organizó en cuatro momentos: 1. Priorización de temáticas; 2. validación de preguntas con equipo AT-PIC y referentes; 3. búsqueda y selección sistemática de evidencia y síntesis, y 4. construcción de pautas/lineamientos con consenso informal.

7.1 Priorización de temas

El proceso de priorización de temáticas para desarrollar cinco herramientas basadas en evidencia en el marco del PICF inició con una identificación preliminar de problemáticas mediante triangulación de fuentes (seguimiento PICF, cruce con núcleos/respuestas del Plan Territorial de Salud y ASIS), delimitando desde el inicio temas con alta posibilidad de intervención directa por los equipos básicos (acciones clínicas, seguimiento familiar, educación, detección temprana y articulación con RIAS) y excluyendo determinantes estructurales cuyo abordaje principal no es sanitario. Posteriormente, se aplicó una priorización multicriterio con cinco criterios explícitos (magnitud, severidad, inequidad, factibilidad y alineación), con ponderaciones sugeridas (25%, 20%, 20%, 25% y 10%, respectivamente) y un esquema de votación 1–5 con reglas de inclusión/exclusión por acuerdo ≥80%, utilizando una técnica tipo Delphi con calificación ciega por expertas/os.

La priorización se realizó en dos rondas con dos grupos: primero el equipo de Asistencia Técnica del PIC (ronda 1) y luego el equipo de Promoción y Prevención (ronda 2), incorporando además temáticas nuevas sugeridas al final del cuestionario para ser consideradas en la segunda ronda. Finalmente, tras comparar resultados de la segunda ronda, se definieron las cinco temáticas seleccionadas para la vigencia: (i) riesgo cardiovascular familiar, (ii) consumo de riesgo y problemático de alcohol, (iii) salud del cuidador en hogares con dependencia/cronicidad, (iv) valoración y cuidado integral de la persona mayor (vejez) y (v) cuidados en el hogar para familias con recién nacidos y mujeres en posparto.

7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras.

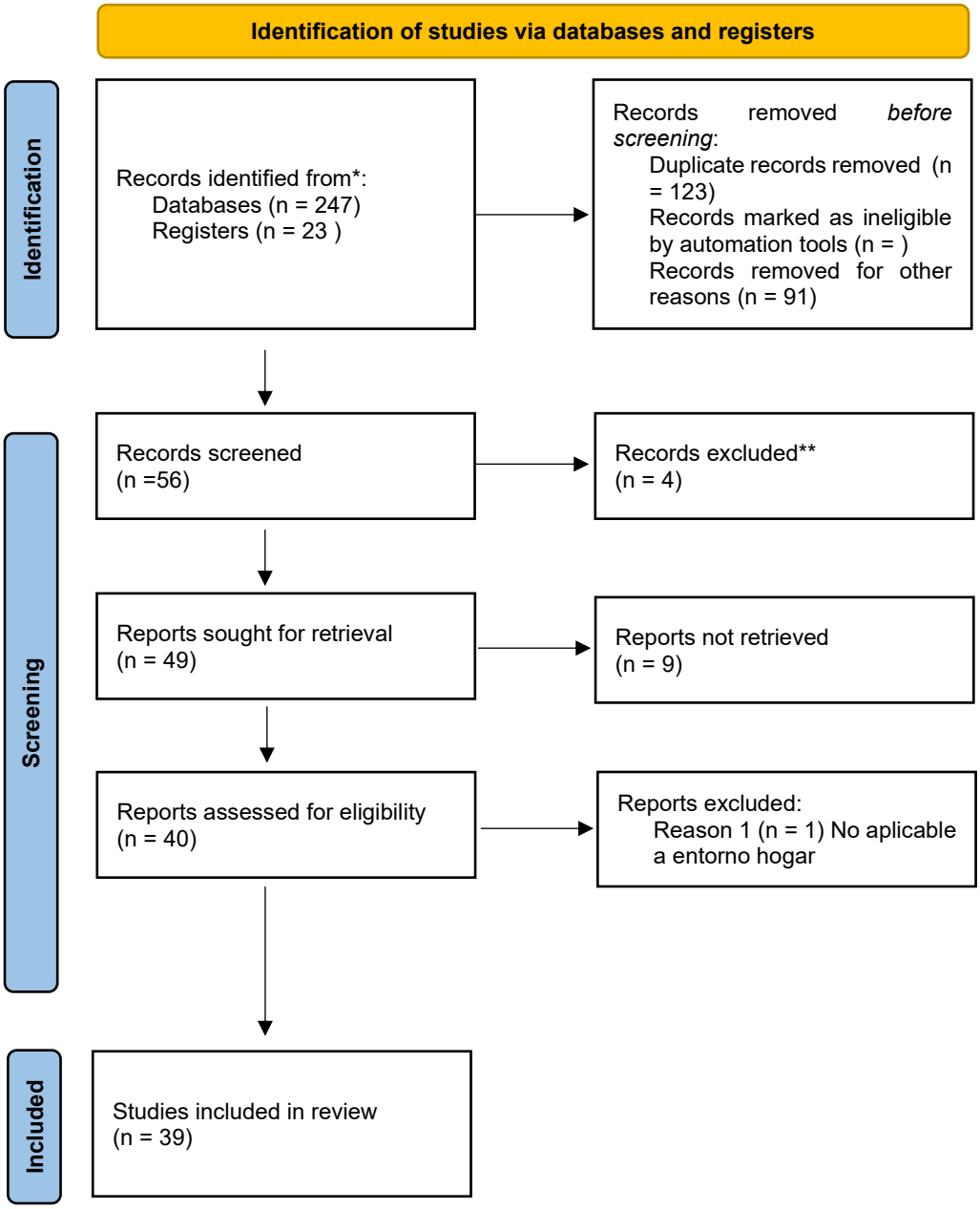
A partir de la triangulación de fuentes sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos y de interacción con algunos equipos de salud, se construyeron las preguntas orientadoras, las cuales se socializaron y validaron con el equipo y referentes por medio de sesiones deliberativas. Este proceso sigue el modelo de lineamientos que contempla reuniones para discutir, ajustar y consensuar alcance y preguntas.

7.3 Búsqueda y selección de la evidencia.

Para responder a cada pregunta, se realizó una búsqueda sistemática estructurando ecuaciones de búsqueda a partir de términos indexados entre marzo y junio de 2026. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: MEDLINE, Cochrane y LILACS, complementada con literatura gris mediante Google Académico.

La estrategia incluyó (i) una búsqueda para identificar Guías de Práctica Clínica (GPC) recientes y (ii) una búsqueda para identificar revisiones sistemáticas, con búsquedas independientes por pregunta cuando fue necesario. Los criterios de inclusión fueron: evidencia aplicable al entorno hogar, acorde con la población objeto, revisiones sistemáticas de literatura, guías de práctica clínica, consensos basados en la evidencia, publicaciones en inglés o español, sin límite de año. Las RSL se verificaron con la lista de chequeo AMSTAR; AGREE para el caso de las GPC, y ACCORD para el caso de los consensos.

El siguiente es el PRISMA de la revisión realizada.


Identification of studies via databases and registers
Identification
Records identified from*:
Databases (n = 247)
Registers (n = 23)
Records removed *before screening*:
Duplicate records removed (n = 123)
Records marked as ineligible by automation tools (n =)
Records removed for other reasons (n = 91)
Screening
Records screened
(n =56)
Records excluded**
(n = 4)
Reports sought for retrieval
(n = 49)
Reports not retrieved
(n = 9)
Reports assessed for eligibility
(n = 40)
Reports excluded:
Reason 1 (n = 1) No aplicable a entorno hogar
Included
Studies included in review
(n = 39)

7.1 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia.

La evidencia incluida se resumió en aspectos clave para las intervenciones recomendadas en el entorno hogar para cada pregunta (beneficios/daños, desempeño de instrumentos de estratificación, factibilidad, recursos, equidad, aceptabilidad), privilegiando la síntesis narrativa. Con base en esto y en la experiencia del equipo clínico y territorial, se elaboraron pautas preliminares que posteriormente se sometieron a discusión y consenso por parte del grupo de referentes de la secretaria de salud del departamento.

7.2 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión.

Las pautas preliminares se discutieron rondas sincrónicas y asincrónicas con cuatro tipos de actores: 1. Expertas familiaristas vinculadas al proceso de implementación de las unidades de análisis del PIC. 2. Referentes de la secretaria de salud de Boyacá,3. Equipos territoriales, buscando asegurar pertinencia territorial y aplicabilidad en el entorno hogar y 4. Equipo docente de la especialidad de medicina familiar de la UPTC. La aprobación de cada pauta se realizó mediante deliberación y acuerdo informal.

8. Resultados

8.1 Marco global para el abordaje de los riesgos y daños relacionados con el alcohol

Los documentos de contexto identificados fueron: el Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022–2030(13), el paquete técnico SAFER(14) y su informe de implementación de 2026(15), así como la estrategia mundial para la reducción del consumo de alcohol(16), todos de la Organización Mundial de la salud, los cuales constituyen marcos normativos y programáticos que orientan la interpretación de la evidencia, pero no reemplazan las revisiones sistemáticas utilizadas para estimar la efectividad de las intervenciones.

En conjunto, plantean, como ya se mencionó, que los daños relacionados con el alcohol no se limitan a los trastornos por consumo ni a las consecuencias experimentadas por quien bebe. Comprenden

enfermedades, lesiones, violencia, afectaciones económicas y sociales y daños ocasionados a otras personas, particularmente niños, adolescentes, mujeres gestantes, parejas, personas dependientes y grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estos daños están determinados por la cantidad y el patrón de consumo, los episodios de embriaguez, el contexto en que se consume, las desigualdades sociales, la disponibilidad y asequibilidad de las bebidas y las prácticas comerciales que favorecen su normalización. Por ello, la respuesta no puede descansar exclusivamente en las decisiones individuales ni en la capacidad de cuidado de las familias.

El Plan de Acción Mundial propone intensificar la aplicación de la Estrategia Mundial mediante seis esferas articuladas: implementación de estrategias e intervenciones de gran impacto; promoción, concienciación y compromiso; asociación, diálogo y coordinación; apoyo técnico y desarrollo de capacidades; generación de conocimiento y sistemas de información; y movilización de recursos. Sus principios priorizan la salud pública, la equidad, los derechos humanos, la adaptación cultural y territorial, la protección de quienes sufren los efectos del consumo de terceros y el acceso de las personas y familias afectadas a servicios eficaces, asequibles y no estigmatizantes. En consecuencia, las pautas de cuidado deben integrarse con la atención primaria, los servicios de salud mental, las rutas de urgencias y protección, la acción comunitaria y las respuestas intersectoriales, en lugar de constituirse como una intervención aislada del sistema de salud y de las condiciones del territorio.

El paquete SAFER, incluido en el Plan de Acción Mundial, operacionaliza de manera articulada cinco intervenciones de alto impacto y costo-eficacia: fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol; impulsar y hacer cumplir las medidas contra la conducción bajo sus efectos; facilitar el acceso al tamizaje, las intervenciones breves y el tratamiento; aplicar prohibiciones o restricciones integrales a la publicidad, el patrocinio y la promoción; y aumentar los precios mediante impuestos y políticas de precios. El efecto del paquete SAFER se potencia cuando varias de sus intervenciones se implementan de manera simultánea y coordinada; por ejemplo, aumentar los precios sin regular la publicidad tendría un impacto limitado en el logro de los objetivos propuestos. Para estos lineamientos resulta especialmente relevante la tercera intervención, que incluye detección temprana, intervención breve, tratamiento de los trastornos por consumo, atención integrada de las comorbilidades y apoyo a las familias(14,15). Sin embargo, las demás medidas también son determinantes para el entorno familiar, porque modifican la disponibilidad de alcohol, la exposición de niños y

adolescentes a la comercialización, las normas sociales, la conducción bajo sus efectos y las oportunidades cotidianas de consumo(15).

SAFER establece además tres condiciones transversales: implementar, dar seguimiento y proteger. Implementar implica adaptar las intervenciones al contexto, definir responsabilidades, disponer de financiamiento, fortalecer capacidades y coordinar sectores y niveles de gobierno. Dar seguimiento exige medir no solo el consumo, sino también los daños clínicos, familiares y sociales, la cobertura de los servicios, la continuidad de la atención y las desigualdades. Proteger supone preservar la formulación de políticas y los mensajes educativos frente a conflictos de interés e interferencias comerciales, evitando que conceptos como "consumo responsable" trasladen toda la carga de prevención a las personas y familias o minimicen el papel de la disponibilidad, el precio y la mercadotecnia(14).

Las experiencias de implementación documentadas hasta 2026 muestran que la adopción formal de políticas es insuficiente cuando no existe una cadena coherente que conecte regulación nacional, capacidad territorial, acción comunitaria y servicios accesibles. Los avances descritos en Uganda, Nepal e Irlanda resaltan la utilidad de integrar el tamizaje, la intervención breve y la remisión en atención primaria; desarrollar protocolos, materiales y capacitación; fortalecer la participación de autoridades locales y sociedad civil; y establecer mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas(15). También identifican como barreras recurrentes la fragmentación institucional, el financiamiento limitado, la debilidad de los sistemas de información, la normalización social del alcohol y la interferencia de los intereses comerciales de la industria del alcohol. Estas experiencias constituyen evidencia programática de implementación y no demostraciones causales de efectividad, pero aportan criterios relevantes para la factibilidad y sostenibilidad de los lineamientos(15).

En este marco, las pautas de cuidado sobre consumo de alcohol en la familia deberán concebirse como un componente de una respuesta escalonada y multinivel: identificar tempranamente riesgos y daños; proteger a los integrantes expuestos; ofrecer intervenciones breves y apoyo familiar cuando sean pertinentes; activar servicios de mayor intensidad, urgencias o protección; acompañar la vinculación y continuidad de la atención; fortalecer entornos familiares y comunitarios que no normalicen ni faciliten el consumo; y comunicar los riesgos sin estigmatizar ni responsabilizar exclusivamente a la familia. Su aplicación deberá incorporar equidad, curso de vida, seguridad, participación familiar voluntaria, adaptación territorial, monitoreo de resultados y articulación con las políticas poblacionales de disponibilidad, precio,

publicidad y conducción bajo los efectos del alcohol, puesto que, de lo contrario, las acciones tendrán un efecto limitado.

El abordaje familiar de los riesgos y daños relacionados con el consumo de alcohol debe procurar coherencia entre los mensajes educativos, las prácticas cotidianas del hogar y el contexto comunitario en el que vive la familia. La evidencia muestra que las actitudes de madres, padres y cuidadores frente al alcohol, la comunicación específica sobre su consumo, las reglas familiares y el ejemplo ofrecido por las personas adultas forman parte del entorno en el que niños, niñas y adolescentes construyen normas y significados sobre el alcohol. Algunos programas dirigidos a familias han logrado modificar favorablemente actitudes parentales, comunicación y reglas específicas, aunque la evidencia no demuestra de manera consistente que estos cambios, por sí solos, reduzcan el consumo adolescente. Por ello, los mensajes de prevención deben traducirse en conductas observables y coherentes, por ejemplo, no ofrecer alcohol a menores, no trivializar la embriaguez, evitar que el consumo interfiera con el cuidado, conversar abiertamente sobre los riesgos y mantener reglas comprensibles y consistentes con lo que las personas adultas practican.

Al mismo tiempo, la familia no se encuentra aislada de su entorno. La disponibilidad de alcohol, las normas sociales, la publicidad, las prácticas comunitarias y las relaciones con pares pueden reforzar o contradecir lo que se promueve dentro del hogar. Por ello, fortalecer a la familia puede entenderse como trabajar desde adentro para afectar el afuera: una familia que reconoce sus riesgos acuerda prácticas de cuidado, comunica de manera coherente y participa activamente en las decisiones cuenta con mayores capacidades para relacionarse críticamente con las presiones del entorno, movilizar apoyos y promover prácticas protectoras en sus redes cercanas. Esta capacidad, sin embargo, debe complementarse con acciones comunitarias, institucionales y poblacionales, ya que la prevención no puede descansar exclusivamente en las familias ni exigirles modificar condiciones estructurales que exceden su capacidad de acción.

8.2 Síntesis narrativa de la evidencia

8.2.1 Pregunta 1

En familias con uno o más integrantes que presentan consumo de alcohol asociado con riesgos o daños, ¿qué intervenciones familiares, domiciliarias o articuladas con la atención primaria son efectivas y factibles para prevenir, reducir o manejar los daños individuales, familiares y del entorno?

Para responder esta primera pregunta se incluyeron 26 documentos publicados entre 2011 y 2026. De ellos, 19 aportaron principalmente evidencia sobre efectividad de intervenciones breves, digitales, psicosociales, integradas, parentales o familiares, de reducción de daños y de abordaje durante el embarazo; mientras que siete aportaron evidencia complementaria sobre factibilidad, barreras y facilitadores de implementación, vinculación con servicios, formación del talento humano y costo-efectividad.

El cuerpo documental estuvo conformado predominantemente por revisiones sistemáticas, incluidas revisiones con metaanálisis y metarregresión, cuatro revisiones Cochrane, tres revisiones paraguas o de revisiones, revisiones cualitativas de implementación y revisiones de evaluaciones económicas; adicionalmente, se incluyó una declaración de recomendación del USPSTF sustentada en una revisión de la evidencia. En conjunto, los documentos permitieron analizar tanto la efectividad de las intervenciones como las condiciones necesarias para articularlas con el nivel primario, el entorno familiar y un paquete escalonado de atención, aunque la evidencia específicamente domiciliaria y dirigida a la familia como unidad de intervención fue más limitada que la disponible para intervenciones individuales realizadas desde los servicios de salud.

Con base en la evidencia disponible e indirecta que pudo identificarse, es posible establecer que existe respaldo consistente para la detección y la intervención breve dirigidas a adultos con consumo perjudicial o de riesgo atendidos en el nivel primario; hay evidencia específica, aunque más limitada, para madres y padres consumidores, gestantes y personas con trastorno por consumo de alcohol y comorbilidades. En contraste, sigue siendo escasa la evidencia sobre intervenciones implementadas directamente en el hogar y dirigidas a la familia como unidad de intervención.

- ***Intervención breve articulada con el nivel primario***

La evidencia más robusta respalda la intervención breve en adultos con consumo perjudicial o de riesgo que no buscan tratamiento especializado. Kaner et al. incluyeron 69 estudios con 33.642 participantes y encontraron que, a los 12 meses, quienes recibieron una intervención breve consumieron aproximadamente 20 g menos de alcohol por semana que quienes recibieron atención mínima o ninguna intervención. La certeza fue moderada, aunque existió heterogeneidad sustancial. Los efectos sobre episodios de consumo intenso, días de consumo e intensidad fueron pequeños, y las intervenciones extendidas no mostraron una ventaja consistente frente a las breves(8,17).

Platt et al. confirmaron un efecto pequeño pero significativo sobre la cantidad consumida, con un tamaño de efecto global de −0,15. Ni el escenario ni el contenido explicaron de forma consistente las diferencias entre intervenciones. Las realizadas por enfermería presentaron el mayor efecto sobre la cantidad consumida, mientras que el consejo breve, la entrevista motivacional y las modalidades motivacionales ampliadas mostraron resultados generalmente favorables, sin evidencia suficiente para establecer que una técnica sea universalmente superior(18).

Las revisiones de Joseph y Basu y Ghosh et al. muestran que las intervenciones breves también pueden implementarse en países de ingreso medio o bajo, aunque los efectos son pequeños y frecuentemente se reducen después de los primeros meses. La evidencia no sustenta una intervención única como respuesta definitiva, sino un primer escalón seguido de valoración de resultados, refuerzo o escalamiento según persistencia del consumo y presencia de daños(19,20).

En términos operativos, una intervención breve debería incluir:

- Retroalimentación comprensible sobre el patrón de consumo y los riesgos identificados.
- Relación entre el consumo y los daños clínicos, familiares o sociales presentes.
- Exploración de disposición al cambio.
- Consejo personalizado y no moralizante.
- Definición de una meta inicial.
- Identificación de obstáculos y apoyos.
- Plan de seguimiento.

La evidencia corresponde principalmente a personas adultas con consumo perjudicial o de riesgo, sin dependencia grave y que no consultan específicamente por alcohol. No debe extrapolarse como tratamiento suficiente para trastorno por consumo de alcohol moderado o grave.

- ***Intervenciones en madres, padres y personas cuidadoras***

La evidencia de aplicación familiar más directa procede de McGovern et al(8). Las intervenciones psicosociales dirigidas a madres y padres consumidores redujeron la frecuencia de consumo de alcohol a los seis y doce meses. El efecto fue mayor cuando las intervenciones combinaron componentes de tratamiento del consumo con componentes de parentalidad; las intervenciones dirigidas exclusivamente al consumo o exclusivamente a habilidades parentales no mostraron efectos significativos sobre el consumo(8).

Este hallazgo sustenta que, cuando quien consume tiene responsabilidades parentales o de cuidado, la intervención no debe

limitarse a aconsejar "beber menos". Debe explorar y abordar de manera integrada:

- Cómo el consumo afecta la supervisión, disponibilidad emocional y respuesta a necesidades.
- Situaciones en las que la persona cuida bajo efectos del alcohol.
- Organización de rutinas y disponibilidad de un cuidador alternativo seguro.
- Comunicación y resolución de conflictos.
- Protección de niños, niñas y otras personas dependientes.
- Barreras para acceder al tratamiento.
- Estrategias para recuperar o sostener las funciones de cuidado.
- Modificación de las pautas y patrones de consumo de alcohol asociados a fiestas y celebraciones familiares.

La participación de la familia debe acordarse con la persona y condicionarse a que sea segura. Los hijos no deben asumir responsabilidad por controlar el consumo ni por garantizar la recuperación de sus padres.

- ***Prevención familiar del consumo en adolescentes***

Sobre programas familiares para adolescentes, la revisión Cochrane de Foxcroft y Tsertsvadze de 2011 encontró pequeños efectos positivos y persistentes en varios ensayos(21). Sin embargo, la revisión posterior de Gilligan et al., que incluyó 46 estudios y 39.822 participantes, no encontró beneficios claros de las intervenciones familiares frente a atención habitual en prevalencia, frecuencia o volumen del consumo. El efecto sobre volumen fue muy pequeño y limítrofe, y la certeza de la evidencia fue baja o muy baja. Tampoco se encontró un beneficio claro al añadir participación parental a intervenciones dirigidas a jóvenes (22).

Hurley et al. encontraron que algunos programas sí modificaron desenlaces parentales: actitudes más restrictivas frente al consumo en menores, mejor comunicación específica sobre alcohol y reglas más claras. No se observaron efectos consistentes sobre monitoreo parental. Además, ningún programa fue calificado como metodológicamente fuerte, y la mayoría tuvo calidad débil(23).

Por tanto, deben separarse dos conclusiones, una sobre las prácticas parentales, en la cual algunos programas pueden mejorar actitudes, comunicación y reglas. Y otra, sobre el consumo adolescente, dónde no existe evidencia suficientemente consistente para afirmar que los programas familiares reduzcan por sí solos la prevalencia o frecuencia del consumo.

Esta distinción evita convertir factores protectores que se observan e indagan en la familia como: comunicación, normas, supervisión o cohesión, en recomendaciones de efectividad sin demostrar que una intervención concreta logró modificarlos y, a su vez, reducir el consumo o los daños.

La orientación familiar puede promover reglas claras, no suministro de alcohol, comunicación respetuosa y vigilancia acorde con la edad, pero estas acciones deben presentarse como componentes razonables de un entorno protector y no como estrategias con eficacia demostrada de manera concluyente para prevenir el consumo adolescente.

- ***Intervenciones digitales y seguimiento en el hogar***

Las intervenciones digitales (denominadas en la literatura intervenciones electrónicas o e-intervenciones) muestran efectos pequeños o moderados a corto plazo, con pérdida de efecto a medida que aumenta el seguimiento. Donoghue et al. encontraron reducciones significativas hasta antes de 12 meses(24); Dedert et al. estimaron una reducción aproximada de una bebida por semana a los seis meses, sin beneficios claros a los doce meses(25); y Tansil et al. encontraron reducciones en frecuencia e intensidad del consumo episódico intenso, con algunos resultados sostenidos hasta un año(26).

La evidencia de Ramsey et al. sugiere que las tecnologías son más efectivas cuando existe participación profesional y una estrategia explícita para integrarlas en la atención. La simple disponibilidad de una aplicación o plataforma no garantiza uso sostenido ni cambio clínicamente relevante(27).

En el PICF, pueden considerarse, entre otras, las siguientes funciones:

- Autorregistro del consumo.
- Recordatorios de metas.
- Retroalimentación personalizada.
- Educación sobre daños.
- Contacto entre visitas.
- Seguimiento de acuerdos.
- Identificación de la necesidad de una nueva valoración.

Antes de utilizarlas deben valorarse conectividad, alfabetización digital, privacidad del dispositivo y posibilidad de control o vigilancia por parte de otros integrantes de la familia.

- ***Reducción de daños y definición de metas***

La reducción del consumo se asocia con beneficios físicos, mentales y sociales. Charlet y Heinz describieron menos lesiones, disminución de

presión arterial, mejoría hepática y cardiaca, reducción de síntomas depresivos y ansiosos y mejor funcionamiento social(28). Dionisi et al. confirmaron que, para la mayoría de los desenlaces, el riesgo aumenta con la cantidad y con los patrones de consumo episódico intenso, y propusieron el mensaje clínico "menos es mejor" en lugar de asumir un umbral universal seguro(29). En consecuencia, la evidencia indica que no existe un nivel de consumo de alcohol que pueda considerarse seguro para la salud; la opción de menor riesgo es no consumir.

En personas que no alcanzan inmediatamente la abstinencia, la familia puede apoyar metas de reducción y prevención de situaciones de alto riesgo. No obstante, es fundamental que se sepa e informe de manera contundente que la reducción de daños:

- No significa ausencia de riesgo.
- No debe utilizarse para justificar consumo durante el embarazo. Es necesario precisar que el consumo de alcohol durante la gestación puede ocasionar daños irreversibles no solo a la madre, sino también al hijo o hija, como los trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF).
- No reemplaza el manejo de dependencia o abstinencia.
- No es adecuada cuando la persona debe conducir, manejar maquinaria o asumir el cuidado seguro de terceros.
- Debe adaptarse a las enfermedades, medicamentos y vulnerabilidades de cada persona.

- ***Embarazo y situaciones de mayor vulnerabilidad***

Minozzi et al. encontraron que las intervenciones psicosociales breves pueden aumentar la abstinencia continua durante el embarazo, aunque la certeza fue baja y el efecto sobre cantidad consumida fue incierto(30). La recomendación del USPSTF también considera que la detección y la consejería breve tienen un beneficio neto moderado en adultos, incluidas las gestantes(31) .

La familia puede apoyar mediante:

- Eliminación de presiones para beber.
- No ofrecimiento de bebidas alcohólicas.
- No normalización del consumo durante el embarazo.
- Apoyo para asistir a controles.
- Identificación de situaciones desencadenantes.
- Acompañamiento para buscar atención si existe dificultad para suspender el consumo.

El consumo durante el embarazo requiere valoración profesional y exploración de comorbilidades, violencia, uso de otras sustancias y barreras sociales.

- ***Trastorno por consumo de alcohol y comorbilidad***

Para personas con trastorno por consumo de alcohol, especialmente cuando coexisten depresión, trauma u otros problemas mentales, las intervenciones integradas parecen más prometedoras que las intervenciones aisladas. Botwright et al. identificaron efectos duraderos de algunos enfoques de redes sociales, mientras que Hallihan et al. encontraron mejorías en consumo y síntomas depresivos con intervenciones conductuales integradas, aunque con incertidumbre frente a la atención habitual (32).

La orientación familiar puede facilitar apoyo y vinculación, pero no debe convertir a la familia en terapeuta ni en responsable de controlar el consumo. Se requiere atención especializada cuando existe:

- Pérdida persistente de control.
- Dependencia o riesgo de abstinencia.
- Comorbilidad psiquiátrica.
- Daño orgánico significativo.
- Fracaso de intervenciones de menor intensidad.
- Deterioro grave del funcionamiento familiar.
- Riesgo para niños, parejas o personas dependientes.

- ***Remisión y continuidad del cuidado***

Glass et al. encontraron que las intervenciones breves no incrementaron de manera significativa la utilización de servicios especializados, incluso cuando incorporaban elementos de remisión. Este resultado demuestra que detectar, aconsejar y entregar una recomendación de consulta no garantiza continuidad asistencial (33).

La evidencia no identifica todavía una estrategia única de remisión superior, pero indica que el lineamiento no debería terminar con “remitir”. El equipo debe, como mínimo:

- Explicar la razón de la remisión.
- Verificar que la persona comprenda y acepte el plan.
- Identificar barreras de acceso.
- Facilitar el contacto con el servicio.
- Registrar la remisión.
- Verificar posteriormente si se produjo la atención.
- Revalorar el caso cuando no se concrete la vinculación.

La familia puede apoyar cuando exista autorización y su participación sea segura, pero no debe asumir sola la navegación del sistema.

- ***Factibilidad e implementación***

Las revisiones de Chan et al.(34), Derges et al.(35) y Rosário et al.(36) coinciden en que las principales barreras son falta de tiempo, herramientas, capacitación, confianza profesional, definición de responsabilidades y apoyo institucional. También se describen temor a dañar la relación con el usuario y actitudes estigmatizantes frente al consumo.

Blake et al.(37) muestran que el entrenamiento digital puede mejorar conocimientos, confianza y autoeficacia de los profesionales, pero rara vez se ha demostrado que produzca cambios sostenidos en la práctica, la remisión o los desenlaces de salud. Por ello, el entrenamiento digital puede incorporarse, pero debe complementarse con simulación, supervisión, evaluación de competencias y monitoreo de la práctica(37).

La evidencia económica respalda la factibilidad de incorporar detección e intervención breve al nivel primario. Angus et al. encontraron que la mayoría de los modelos las consideraban costo-efectivas o costo-ahorradoras, sin evidencia clara de que la duración o el tipo de profesional alteraran sustancialmente esa conclusión(38). Le et al. también encontraron evidencia favorable para intervenciones breves y para algunos programas escolares combinados con participación parental. Sin embargo, la mayoría de estos análisis se realizó en países de ingresos altos, lo que limita su transferencia directa al contexto territorial colombiano(39).

8.2.2 Pregunta 2

¿Qué herramientas educativas, comunicativas, conductuales, participativas y de planificación pueden utilizarse en el entorno hogar para que las familias reconozcan y modifiquen prácticas cotidianas que incrementan los riesgos y daños relacionados con el consumo de alcohol?

Para responder esta pregunta se incluyeron 15 documentos publicados entre 2014 y 2024, nueve clasificados como evidencia directa y seis como evidencia complementaria. El cuerpo documental estuvo conformado principalmente por revisiones sistemáticas sobre intervenciones breves presenciales y digitales, dos revisiones Cochrane, dos revisiones de revisiones, una revisión cualitativa de implementación, una revisión sistemática de guías, una revisión amplia sobre intervenciones en jóvenes y una revisión clínica. La evidencia se concentra en intervenciones

aplicadas a personas adultas desde el nivel primario y en herramientas digitales, mientras que la evidencia que evalúa directamente cambios en prácticas familiares se encuentra principalmente en los programas dirigidos a madres y padres de adolescentes. Por ello, los hallazgos permiten identificar componentes educativos, comunicativos, conductuales y de planificación transferibles al entorno hogar, pero no demuestran la efectividad de un único paquete integral dirigido a la familia como unidad de intervención.

- ***Alcance y aplicabilidad al entorno familiar***

La evidencia examinada identifica un conjunto relativamente consistente de herramientas para promover el reconocimiento del riesgo y apoyar modificaciones conductuales, pero la mayoría ha sido evaluada con personas individuales en atención primaria, universidades o medios electrónicos. Solo una revisión evaluó directamente resultados parentales de programas orientados a prevenir el consumo en adolescentes. En consecuencia, los hallazgos permiten definir componentes transferibles al trabajo domiciliario, pero no permiten afirmar que todas las herramientas hayan sido evaluadas con la familia como unidad de intervención ni que su incorporación conjunta produzca necesariamente mejores resultados.

Las herramientas identificadas se agrupan en cinco categorías: retroalimentación educativa individualizada; comunicación breve, empática y no estigmatizante; técnicas motivacionales y conductuales; instrumentos para establecer metas, planes y seguimiento; y recursos digitales que amplían el acceso y permiten autorregistro. En familias con adolescentes se añaden comunicación específica sobre alcohol, revisión de las actitudes parentales y establecimiento de reglas claras. La participación de la familia en el diseño de las herramientas aparece como una condición deseable para mejorar pertinencia y aceptabilidad, aunque todavía no cuenta con evidencia suficiente para afirmar que incrementa directamente su efectividad.

- ***Retroalimentación educativa sobre riesgos y daños***

La herramienta educativa con mayor presencia en la evidencia es la retroalimentación personalizada, elaborada a partir del patrón de consumo, las situaciones en que se bebe y las consecuencias identificadas(18,23). Las intervenciones breves presenciales y digitales comunican cómo se compara el consumo de la persona con criterios de riesgo, explican sus posibles consecuencias físicas, mentales y sociales y relacionan el alcohol con problemas concretos ya presentes. Esta retroalimentación puede acompañarse de información escrita o digital que la persona y la familia puedan revisar posteriormente(17,24,25,40,41).

La retroalimentación debe ser comprensible, específica y vinculada con la vida cotidiana. En el entorno hogar puede orientarse a reconocer, por ejemplo, episodios de consumo antes o durante el cuidado de otras personas, conflictos recurrentes, gastos que afectan necesidades básicas, conducción, accidentes, ausencias laborales, interrupción de rutinas o exposición de niños y adolescentes. La evidencia no sustenta la educación basada exclusivamente en mensajes generales sobre los daños. En población joven, las intervenciones que incorporan entrenamiento de habilidades parecen más prometedoras que la simple transmisión de información(42).

La comparación normativa, que informa cómo se ubica el consumo de la persona frente al de otras personas de edad o sexo similares, es frecuente en las intervenciones digitales. No obstante, la evidencia no establece que sea superior a la retroalimentación personalizada centrada en riesgos y consecuencias. Por ello, puede emplearse como un recurso adicional, pero no debería constituir el núcleo de la orientación familiar ni utilizarse de forma que normalice el consumo frecuente bajo el argumento de que otras personas beben más (24,26).

- ***Comunicación empática, colaborativa y no estigmatizante***

Las revisiones convergen en que la forma de comunicar es tan importante como el contenido. Las herramientas deben aplicarse mediante escucha reflexiva, empatía, respeto por la autonomía, ausencia de confrontación y lenguaje no moralizante. Los modelos FRAMES y FLAGS organizan esta conversación alrededor de la retroalimentación, la responsabilidad personal, el consejo, la presentación de opciones, la empatía, la autoeficacia, la escucha, las metas y las estrategias (40).

La entrevista motivacional aporta un estilo colaborativo para vincularse con la persona, focalizar el comportamiento que se desea modificar, explorar sus propias razones para cambiar y planificar acciones. Sin embargo, las revisiones de Frost et al. y Schwenker et al. muestran que sus efectos suelen ser pequeños, dependen del comparador y se concentran principalmente en el corto plazo. No ha demostrado superioridad consistente frente a otras intervenciones activas y no existe claridad sobre su efecto en la disposición al cambio o la permanencia en tratamiento (43,44).

En consecuencia, la entrevista motivacional debería entenderse como un estilo y conjunto de habilidades comunicativas, no como una herramienta aislada que garantice el cambio. Puede utilizarse para explorar ambivalencias, evitar discusiones, identificar razones significativas para la persona y favorecer que los compromisos sean formulados por ella misma. Cuando participe la familia, la conversación debe evitar alianzas

coercitivas, señalamientos colectivos o intentos de vigilancia que puedan aumentar el conflicto.

Las barreras descritas por profesionales muestran que la conversación sobre alcohol puede evitarse por temor a ofender, deteriorar la relación o generar estigma. La capacitación mejora conocimiento y confianza, pero no es suficiente si no existen roles claros, tiempo, respaldo institucional y una ruta para dar respuesta a los hallazgos. Por ello, toda herramienta comunicativa debe estar integrada a un proceso que defina qué hará el equipo después de identificar el riesgo (35).

- ***Herramientas conductuales y de planificación***

La evidencia respalda una secuencia de intervención breve que no se limita a informar. Después de reconocer el patrón de consumo y sus consecuencias, la persona debe identificar situaciones de alto riesgo, seleccionar una meta y definir un plan personal. Los componentes más frecuentes son:

1. Valoración y retroalimentación directa.
2. Identificación de situaciones, emociones, personas o rutinas relacionadas con el consumo.
3. Selección conjunta de una meta de reducción o abstinencia, según el nivel de riesgo.
4. Definición de estrategias concretas para afrontar las situaciones identificadas.
5. Autorregistro del consumo, los desencadenantes y las consecuencias.
6. Seguimiento, refuerzo y revisión del plan.

Kaner et al. encontraron que estos componentes pueden reducir modestamente el consumo hasta los 12 meses y que aumentar la duración o el número de sesiones no produce necesariamente mejores resultados(17,45). Esto favorece la utilización de herramientas sencillas y estructuradas, adaptables a una visita domiciliaria, siempre que no se omita el seguimiento(46).

Los modelos FRAMES y FLAGS agregan dos elementos relevantes para el hogar, ofrecer un menú de opciones y establecer las metas conjuntamente con la persona(17). En lugar de imponer una conducta, el equipo puede ayudar a seleccionar entre alternativas realistas, por ejemplo, retirar el alcohol de determinados espacios, evitar beber durante responsabilidades de cuidado, modificar rutinas asociadas con consumo, limitar situaciones de disponibilidad, elegir actividades alternativas, solicitar apoyo o acceder a atención profesional. La evidencia respalda la planificación individual, pero la incorporación de acuerdos familiares

específicos debe realizarse con consentimiento y valorar que no exista violencia, coerción o sobrecarga de otros integrantes(47,48).

El seguimiento es un componente necesario porque los efectos de las intervenciones breves y digitales tienden a disminuir con el tiempo. Puede incluir revisión del autorregistro, dificultades encontradas, cumplimiento de metas, aparición de nuevos daños y necesidad de modificar el plan. La ausencia de efecto sostenido después de 12 meses en varias revisiones sugiere que la herramienta no debe entregarse una sola vez sin contacto posterior(8,32,35).

- ***Herramientas digitales para uso en el hogar***

Los medios electrónicos comprenden páginas web, aplicaciones móviles, tabletas, computadores, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas automatizadas, respuesta de voz interactiva y autorregistros digitales. Sus componentes más frecuentes son detección, retroalimentación personalizada, información sobre consecuencias, consejo, establecimiento de metas, monitoreo y mensajes de seguimiento. Algunos programas permiten uso totalmente autónomo, mientras otros incorporan llamadas, consejería o revisión por profesionales(8,24,27,35).

Los resultados muestran efectos favorables, aunque generalmente pequeños y de duración limitada. Las intervenciones digitales reducen el consumo a corto y mediano plazo, pero su efecto suele disminuir hacia los 12 meses. Ramsey et al. encontraron mejores resultados cuando existía participación profesional y una estrategia definida para integrar la tecnología en la atención. Dedert et al. plantearon que una mayor intensidad y algún grado de apoyo humano podrían mejorar la permanencia del efecto (24,32).

En el entorno hogar, estas herramientas pueden utilizarse para:

- Registrar días, cantidades y circunstancias del consumo.
- Recibir retroalimentación individualizada.
- Recordar metas y compromisos.
- Consultar contenidos educativos.
- Revisar situaciones de riesgo.
- Mantener contacto con el equipo entre visitas.
- Identificar la necesidad de una nueva valoración.

Su uso requiere verificar alfabetización digital, acceso a dispositivos, conectividad, comprensión del contenido y privacidad. Tansil et al. advierten que las herramientas mal diseñadas pueden utilizar pruebas no validadas o proporcionar recomendaciones inapropiadas. La protección de los datos es especialmente importante cuando el dispositivo es

compartido o cuando existe control de las comunicaciones por otro integrante de la familia (49).

La revisión de Villanueva-Blasco et al. identificó intervenciones digitales potencialmente recomendables para alcohol, pero también una considerable heterogeneidad y programas de muy baja calidad. Por ello, los nombres comerciales o plataformas específicas no deberían incorporarse automáticamente al lineamiento. Resulta más apropiado estandarizar sus componentes mínimos, su vinculación con el equipo y los criterios para determinar cuándo la herramienta digital no es suficiente (49).

- ***Herramientas dirigidas a familias con adolescentes***

La evidencia directamente relacionada con prácticas familiares proviene de los programas parentales. Hurley et al. encontraron cambios favorables en actitudes parentales, comunicación específica sobre alcohol y establecimiento de reglas restrictivas. Cuatro de cinco programas que evaluaron comunicación informaron efectos significativos, mientras que los programas que midieron monitoreo parental no encontraron cambios(34).

Estos hallazgos permiten identificar como herramientas potenciales:

- Conversaciones planificadas y apropiadas para la edad sobre alcohol y sus consecuencias.
- Expresión clara de la posición de los padres frente al consumo en menores.
- Reglas específicas sobre no consumo y no suministro de bebidas alcohólicas.
- Preparación de respuestas frente a presión de pares o situaciones sociales.
- Revisión del ejemplo y de las prácticas de consumo de las personas adultas.
- Acuerdos sobre qué hacer cuando el adolescente se encuentre en una situación de riesgo.

No obstante, debe conservarse la distinción metodológica acordada. La asociación observacional entre supervisión parental y menor consumo no demuestra que una intervención logre mejorar la supervisión ni que ese cambio reduzca el consumo. En la revisión de Hurley, los programas no modificaron el monitoreo parental. Por tanto, la supervisión puede valorarse como una condición familiar relevante, pero no presentarse como una herramienta de eficacia demostrada mediante los programas incluidos (34).

La revisión de Stockings et al. refuerza que las acciones con jóvenes deben desarrollar habilidades y no limitarse a proporcionar información. También advierte que las intervenciones breves y las estrategias basadas en normas sociales no cuentan con evidencia sólida en esta población. Las herramientas deben adecuarse a la edad, el nivel de consumo, la autonomía progresiva y el contexto social, evitando trasladar directamente intervenciones diseñadas para personas adultas (42).

- ***Herramientas participativas y adaptación a las familias***

La participación de las familias y otros actores en el diseño de los programas fue escasa. Hurley et al. encontraron poca vinculación de padres, comunidades y otros interesados durante el desarrollo de las intervenciones, y un uso limitado o insuficientemente descrito de teorías de cambio conductual. Los autores plantean que incorporar las perspectivas de quienes utilizarán las herramientas podría mejorar aceptación, pertinencia y sostenibilidad, pero la revisión no demuestra que la participación produzca directamente mejores desenlaces de consumo (34,50).

En el entorno hogar, la participación puede operacionalizarse permitiendo que la familia:

- Seleccione los riesgos o prácticas que considera prioritarios.
- Describa sus propias rutinas, recursos y barreras.
- Proponga alternativas compatibles con su cultura y territorio.
- Elija quiénes participarán en los acuerdos.
- Defina metas alcanzables.
- Revise y ajuste los compromisos durante el seguimiento.

Este proceso debe entenderse como una condición para adaptar y concertar el plan de cuidado, no como una intervención cuya efectividad independiente haya sido establecida.

En términos generales, la evidencia permite configurar un conjunto de herramientas aplicables al entorno hogar, sin plantearlas como una lista aislada ni como materiales educativos autosuficientes. El proceso puede comenzar con una valoración del consumo y de las prácticas cotidianas asociadas, seguida de retroalimentación personalizada sobre riesgos y daños. Posteriormente se utiliza una conversación empática, no confrontativa y centrada en la persona, para explorar disposición al cambio, seleccionar una meta y formular un plan. El plan puede apoyarse en autorregistros, materiales escritos o digitales, recordatorios y seguimiento profesional.

En familias con adolescentes, este proceso debe incorporar comunicación específica, reglas claras, no suministro de alcohol y análisis del ejemplo

que ofrecen las personas adultas. En familias con personas adultas que consumen, las herramientas deben centrarse en las prácticas que generan riesgos concretos, sin responsabilizar al grupo familiar por controlar el consumo ni sustituir la atención clínica.

La evidencia no permite concluir que una sola herramienta sea superior. Tampoco respalda la educación exclusivamente informativa, la entrevista motivacional como intervención autónoma, la entrega aislada de aplicaciones ni la prescripción de prácticas familiares basada únicamente en asociaciones observacionales. Los mejores resultados parecen obtenerse cuando se combinan retroalimentación, comunicación respetuosa, establecimiento conjunto de metas, estrategias conductuales, seguimiento y participación profesional.

Por último, es importante mencionar que las herramientas con mayor sustento para ser adaptadas al entorno hogar son la retroalimentación personalizada, las conversaciones breves estructuradas y no estigmatizantes, los modelos FRAMES o FLAGS, la identificación de situaciones de riesgo, el establecimiento conjunto de metas, los planes personales o familiares, el autorregistro, el refuerzo y seguimiento, y los recursos electrónicos vinculados con el nivel primario. En familias con adolescentes se añaden la comunicación específica sobre alcohol y las reglas claras frente al consumo y suministro. La selección debe adaptarse al curso de vida, severidad, capacidades familiares, condiciones culturales y acceso tecnológico, y debe acompañarse de criterios para escalar la atención cuando las herramientas breves sean insuficientes.

8.2.3 Pregunta 3

¿Qué signos, síntomas, comportamientos, situaciones familiares y condiciones del entorno asociados con el consumo de alcohol indican la necesidad de solicitar atención inmediata, activar rutas de urgencias o protección, o gestionar una valoración prioritaria?

Para responder esta pregunta se incluyeron cinco documentos publicados entre 2015 y 2026: una revisión sistemática de 17 guías de práctica clínica sobre el abordaje del consumo perjudicial de alcohol en el nivel primario, una declaración de recomendación del US Preventive Services Task Force sustentada en una revisión sistemática de la evidencia, una revisión sistemática paraguas sobre riesgos, intervenciones y políticas relacionadas con el alcohol, una revisión sistemática con metaanálisis de intervenciones realizadas con adolescentes y adultos jóvenes atendidos en servicios de urgencias, y una revisión Cochrane sobre intervenciones para reducir o suspender el consumo durante el embarazo.

Los documentos permiten identificar condiciones clínicas, conductuales, familiares y contextuales que justifican atención inmediata o valoración prioritaria, aunque ninguno tuvo como objetivo principal validar una lista de signos de alarma para uso domiciliario. Por esta razón, la clasificación de las señales en atención inmediata, activación de rutas de protección y valoración prioritaria corresponde a una integración operativa de los hallazgos, y no a una escala de triaje validada específicamente para el entorno hogar(29–31,40,51).

- ***Identificación del riesgo y necesidad de clasificar la respuesta***

La evidencia revisada muestra que la decisión de solicitar ayuda no debe basarse únicamente en la cantidad o frecuencia del consumo. Deben valorarse conjuntamente el estado actual de la persona, la posible intoxicación o abstinencia, la ocurrencia de lesiones, la pérdida de control sobre el consumo, la presencia de conductas peligrosas, la afectación de las responsabilidades familiares, la exposición de otras personas a violencia o negligencia y la existencia de condiciones de especial vulnerabilidad.

Un resultado positivo en una pregunta breve, en el AUDIT-C o en otro instrumento de detección debe conducir a una valoración más profunda que permita establecer la severidad, los daños presentes y los pasos siguientes de la atención. Los instrumentos de tamización permiten identificar riesgo, pero no sustituyen la valoración de la seguridad inmediata ni determinan por sí solos la necesidad de urgencias o protección (31,40).

Para la aplicación de los lineamientos en el hogar, los hallazgos pueden organizarse en tres niveles de respuesta: situaciones que requieren atención inmediata, situaciones que exigen activar rutas de protección y condiciones que ameritan una valoración clínica prioritaria, aunque no exista una emergencia manifiesta.

- ***Situaciones que requieren atención inmediata***

La sospecha de intoxicación aguda o envenenamiento por alcohol, especialmente cuando se acompaña de una lesión, accidente, caída, trauma o alteración importante del comportamiento, debe considerarse una situación que requiere atención urgente. La revisión paraguas de Dionisi et al. encontró que cualquier consumo de alcohol durante las seis horas anteriores a una lesión se asociaba con mayores probabilidades de sufrirla, OR 2,80, y reconoció como desenlaces agudos relevantes el trauma, las lesiones de tránsito, la violencia, la intoxicación y el envenenamiento. La revisión también documentó una carga significativa de atenciones hospitalarias atribuibles a intoxicación grave y

dependencia, lo que confirma que estos eventos no deben manejarse exclusivamente mediante observación familiar en el hogar (29).

También requiere atención inmediata una convulsión ocurrida después de reducir o suspender el consumo, debido a que puede corresponder a un síndrome de abstinencia grave. Otros síntomas descritos como manifestaciones de abstinencia son temblor, dificultad para dormir, inquietud, náuseas, sudoración y aceleración del ritmo cardiaco. La presencia aislada de estos síntomas exige valoración prioritaria, mientras que su progresión, la aparición de convulsiones o un deterioro clínico deben conducir a atención de urgencias. La persona y la familia no deberían intentar una suspensión brusca sin valoración profesional cuando existe consumo prolongado, tolerancia, antecedentes de abstinencia o sospecha de dependencia (31).

Los accidentes de tránsito, la conducción después de consumir, las lesiones producidas durante la intoxicación, los episodios de violencia y las situaciones en las que la persona se expone a ahogamiento, caídas, relaciones sexuales inseguras u otros riesgos físicos también constituyen señales para interrumpir la actividad peligrosa y gestionar atención inmediata según el daño ocurrido. Dionisi et al. encontraron una asociación entre el consumo agudo y las lesiones, mientras que Curry et al. incluyeron la participación repetida en situaciones con alta probabilidad de daño, como conducir, nadar o tener conductas sexuales inseguras, entre las manifestaciones relevantes del trastorno por consumo de alcohol (29,31).

En adolescentes y adultos jóvenes, la consulta por intoxicación, trauma, accidente, agresión o cualquier otro evento relacionado con el alcohol representa tanto una urgencia clínica como una oportunidad para evaluar el patrón de consumo y prevenir recurrencias. Kohler y Hofmann incluyeron ensayos realizados con jóvenes de 13 a 25 años atendidos en servicios de urgencias por alcoholemia positiva, trauma relacionado con alcohol, consumo de alto riesgo o conductas agresivas. Estos antecedentes indican que un evento agudo no debe cerrarse únicamente con la resolución de la lesión o la intoxicación, sino que debe continuar con valoración del consumo, intervención breve y seguimiento (51).

Situaciones que requieren activar rutas de protección

El consumo de alcohol puede afectar no solo a quien consume, sino también a niños, niñas, adolescentes, parejas, personas mayores, personas con discapacidad y otros integrantes dependientes del cuidado familiar. Zhang et al. identificaron entre los daños sociales asociados con el consumo perjudicial los accidentes de tránsito, la violencia, el suicidio, el abuso y la negligencia infantil. Por tanto, la presencia o amenaza de

violencia física, sexual o psicológica, el abandono o descuido de niños o personas dependientes y las amenazas de suicidio o daño a otras personas requieren activar las rutas de protección y seguridad correspondientes, además de la atención en salud (40).

La necesidad de protección también debe considerarse cuando el consumo interfiere de forma repetida con las responsabilidades del hogar, la supervisión o el cuidado de otras personas. Entre los criterios de trastorno por consumo de alcohol descritos por Curry et al. se encuentran el incumplimiento de las responsabilidades familiares, laborales o escolares, la persistencia del consumo pese a los conflictos con familiares y amigos, y la participación en situaciones en las que aumenta la posibilidad de lesionarse. Estos comportamientos no necesariamente representan una emergencia médica en todos los casos, pero adquieren prioridad cuando comprometen la seguridad de niños, personas dependientes o integrantes que no pueden protegerse por sí mismos (31).

La activación de la ruta de protección no debe condicionarse a que la persona reconozca el problema, acepte tratamiento o cumpla criterios diagnósticos de dependencia. El criterio central es la existencia de una amenaza o daño para otra persona. La familia tampoco debe ser orientada a confrontar físicamente, controlar por la fuerza o retirar el alcohol en circunstancias que puedan desencadenar agresiones. La valoración debe realizarse procurando privacidad, evitando entrevistar conjuntamente a víctima y posible agresor y definiendo medidas inmediatas de seguridad(18).

Las conductas suicidas, las amenazas de muerte, la expresión de desesperanza extrema, la preparación de medios para hacerse daño o la combinación de intoxicación con ideación suicida deben considerarse situaciones de atención inmediata y no solo como motivos para una consulta programada. Aunque los documentos incluidos no desarrollaron un protocolo específico de evaluación del suicidio, la revisión de guías identificó el suicidio como uno de los daños graves asociados con el consumo perjudicial(40).

- ***Signos de pérdida de control y dependencia que requieren valoración prioritaria***

La evidencia permite reconocer un conjunto de comportamientos que indican que una intervención educativa aislada puede ser insuficiente y que se requiere una valoración clínica prioritaria. Estos incluyen beber más cantidad o durante más tiempo de lo planeado, intentar reducir o suspender el consumo sin conseguirlo, experimentar un deseo intenso o compulsivo de beber, dedicar una cantidad considerable de tiempo a consumir o recuperarse de sus efectos, abandonar actividades

importantes, continuar bebiendo pese a problemas de salud o conflictos familiares, requerir cantidades cada vez mayores para lograr el mismo efecto y presentar síntomas de abstinencia cuando se reduce o suspende el consumo (31).

También ameritan valoración prioritaria los episodios de pérdida de memoria o lagunas durante el consumo, la repetición de lesiones o accidentes, el deterioro del desempeño laboral o escolar y el uso persistente pese a depresión, ansiedad u otros problemas físicos y mentales. Estos hallazgos pueden indicar un trastorno por consumo de alcohol o una mayor severidad del problema. Zhang et al. señalaron que las personas con consumo perjudicial pueden recibir intervenciones breves en el nivel primario, mientras que la dependencia requiere una atención más intensiva y, con frecuencia, participación de servicios especializados (31,40).

Un puntaje elevado en un instrumento como el AUDIT debe interpretarse junto con los daños clínicos y familiares. La revisión de guías encontró que el AUDIT fue el instrumento más recomendado, pero también mostró variaciones en los puntos de corte según sexo, edad, embarazo y contexto cultural. Por ello, la remisión no debe depender exclusivamente de un umbral numérico. La presencia de abstinencia, pérdida de control, deterioro funcional, comorbilidad mental, consumo de otras sustancias o daño familiar puede justificar una valoración prioritaria, aunque el resultado del instrumento no alcance un punto de corte específico (40).

- ***Embarazo y otras condiciones de especial vulnerabilidad***

Durante el embarazo, cualquier consumo de alcohol constituye un hallazgo que requiere valoración prioritaria, debido a que no se ha establecido un nivel seguro de exposición. La revisión Cochrane de Minozzi et al. relacionó el consumo prenatal con aborto espontáneo, parto pretérmino, desprendimiento de placenta, sangrado, infección intraamniótica, muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y alteraciones del desarrollo(30). Las intervenciones psicosociales breves pueden aumentar la abstinencia continua, aunque la certeza de la evidencia es baja y existe escasa evidencia sobre el tratamiento de gestantes con trastorno por consumo de alcohol (30).

La identificación de consumo durante el embarazo debe conducir a una valoración clínica que determine cantidad, frecuencia, episodios intensos, signos de dependencia, consumo de otras sustancias, estado nutricional, salud mental y condiciones sociales. La presencia de sangrado, sospecha de aborto, parto pretérmino, desprendimiento placentario u otra complicación obstétrica asociada requiere atención urgente por la

condición materno-perinatal, independientemente de la cantidad de alcohol consumida(30).

La gestante con pérdida de control, síntomas de abstinencia, consumo intenso o trastorno por consumo de alcohol no debería recibir únicamente el consejo de suspender el consumo. La evidencia disponible es insuficiente para determinar la seguridad y efectividad de los medicamentos para el trastorno por consumo de alcohol durante el embarazo, y solo una parte de los estudios incluyó gestantes con diagnóstico actual o previo. Esto sustenta la necesidad de evaluación especializada y coordinación entre atención prenatal, salud mental y servicios de atención al consumo de sustancias(30).

En personas que toman medicamentos que interactúan con el alcohol, presentan una condición clínica que puede agravarse con su consumo o deben conducir o manejar maquinaria, cualquier consumo puede constituir un riesgo relevante. Dionisi et al. destacaron que el alcohol puede dificultar el control de la presión arterial y la glucemia y aumentar daños por interacciones con medicamentos en personas con multimorbilidad y polifarmacia. Estos hallazgos ameritan valoración prioritaria para revisar el tratamiento, prevenir accidentes y establecer una meta segura de reducción o abstinencia(29,31).

- ***Seguimiento después de un evento agudo***

La atención no debe finalizar una vez se resuelva la intoxicación, lesión o crisis. Kohler y Hofmann mostraron que la atención de urgencias puede funcionar como una oportunidad para intervenir en adolescentes y adultos jóvenes con consumo de riesgo. Las intervenciones motivacionales breves produjeron reducciones pequeñas en la frecuencia del consumo y, en algunos estudios, en la cantidad consumida, aunque sus resultados no fueron uniformes y el consumo tendió a aumentar nuevamente después de los primeros meses. Por ello, el alta debe acompañarse de valoración del nivel de riesgo, información sobre recursos disponibles, vinculación con servicios y seguimiento (51).

La recurrencia de consultas por intoxicación, accidentes, peleas o lesiones constituye una señal de persistencia del riesgo y debe conducir a una evaluación más intensiva. La familia puede apoyar el acceso y el seguimiento, siempre que su participación sea segura y autorizada, pero no debe asumir la responsabilidad exclusiva de vigilar, controlar o tratar a la persona.

En términos generales, la evidencia permite establecer que la atención inmediata debe priorizarse ante sospecha de intoxicación o envenenamiento, lesión o trauma asociado con alcohol, accidente de tránsito, convulsión durante una posible abstinencia, conducta suicida,

violencia aguda o cualquier comportamiento que represente peligro actual para la persona o para terceros. Las rutas de protección deben activarse ante violencia, abuso, negligencia, amenaza suicida, exposición de niños o personas dependientes a situaciones inseguras y deterioro grave de las responsabilidades de cuidado. La valoración prioritaria corresponde a las personas con pérdida de control, tolerancia, abstinencia no complicada, lagunas de memoria, consumo persistente pese a daños, deterioro familiar, laboral o escolar, embarazo, comorbilidad física o mental, interacción con medicamentos, consumo de otras sustancias o antecedentes repetidos de eventos relacionados con alcohol.

Los documentos incluidos no permiten definir tiempos universales de respuesta, puntos de corte únicos ni un instrumento domiciliario que discrimine de manera autónoma entre urgencia, protección y remisión programada. En consecuencia, es fundamental que el equipo combine la valoración del patrón de consumo con la evaluación inmediata de la seguridad, la severidad clínica, los daños a terceros, las responsabilidades de cuidado y las condiciones de vulnerabilidad.

8.2.4 Pregunta 4

¿Qué estrategias educativas, participativas, relacionales y de seguimiento fortalecen la agencia de cuidado de las familias para construir y sostener un entorno protector que no normalice ni facilite el consumo de alcohol, reduzca la exposición a riesgos y daños y permita definir, implementar y monitorear compromisos familiares?

Para responder esta pregunta se revisaron ocho documentos publicados entre 2011 y 2026, correspondientes a siete cuerpos de evidencia independientes, debido a que la publicación de McGovern et al. de 2022 presenta de manera ampliada los principales metaanálisis de la revisión Cochrane publicada por el mismo grupo en 2021. El conjunto documental comprende cuatro revisiones Cochrane, tres revisiones sistemáticas adicionales y un artículo derivado de una de las revisiones Cochrane. Cinco documentos aportan evidencia directa sobre programas familiares, parentales, de pareja o integrados para la prevención o el tratamiento del consumo de alcohol y otras sustancias; una revisión aporta evidencia complementaria sobre entrevista motivacional como estrategia relacional; y una revisión cualitativa aporta evidencia contextual sobre factores familiares observacionales asociados con mayor o menor consumo.

Ninguno de los estudios evaluó explícitamente la *agencia de cuidado familiar*. Por tanto, la respuesta se construye a partir de resultados relacionados con participación familiar, comunicación, establecimiento de

reglas, funcionamiento familiar, habilidades parentales, planificación del cambio, reducción del consumo y seguimiento, diferenciando las intervenciones evaluadas de los factores protectores identificados únicamente mediante estudios observacionales.

La evidencia permite entender la agencia de cuidado familiar como la capacidad de los integrantes para reconocer los riesgos y daños asociados con el alcohol, participar de forma informada en las decisiones, revisar las prácticas que facilitan el consumo, acordar cambios realistas, utilizar sus recursos relacionales y solicitar apoyo cuando las capacidades familiares resultan insuficientes. Esta agencia no equivale a responsabilizar a la familia por controlar a quien consume, ni a reemplazar el tratamiento profesional. Su fortalecimiento requiere que la familia sea reconocida como participante activa, pero que sus responsabilidades estén delimitadas por la seguridad, la autonomía de sus integrantes y la necesidad de atención clínica.

La revisión de Aswathy et al. identificó 15 ensayos aleatorizados de intervenciones familiares para trastornos por consumo de sustancias, 11 de los cuales informaron efectos positivos sobre reducción del consumo, funcionamiento familiar o ambos. Las intervenciones exigían la participación activa de al menos un familiar inmediato e incluían terapias multidimensionales, ecológicas, estratégicas, de pareja y programas integrados para adolescentes. En conjunto, estos modelos abordaban el consumo junto con las relaciones familiares, la comunicación, la solución de problemas, la participación en el tratamiento y la organización del apoyo. Sin embargo, los ensayos fueron heterogéneos, incluyeron alcohol y otras sustancias y evaluaron poblaciones con distintos niveles de severidad, por lo cual no es posible concluir que una modalidad específica sea superior para todas las familias(48).

La evidencia disponible sugiere que la participación familiar es más útil cuando se estructura alrededor de funciones concretas, como comprender el problema, disminuir prácticas facilitadoras, mejorar la comunicación, apoyar el acceso al tratamiento, organizar responsabilidades de cuidado y revisar periódicamente los avances. La simple presencia de un familiar en una sesión o la entrega de información general no constituye por sí sola una intervención familiar efectiva.

- ***Estrategias educativas para reconocer y transformar la normalización del alcohol***

Los programas preventivos dirigidos a madres, padres y cuidadores se han concentrado en modificar actitudes permisivas frente al consumo, mejorar la comunicación específica sobre alcohol y establecer reglas

claras. Foxcroft y Tsertsvadze identificaron como componentes frecuentes el apoyo parental, las conductas de cuidado y afecto, el establecimiento de límites, el monitoreo, el desarrollo de habilidades para resistir la presión de pares y la construcción de normas familiares. Su revisión de 12 ensayos concluyó que los efectos sobre el consumo juvenil eran pequeños, generalmente favorables y potencialmente persistentes, aunque la calidad del reporte de los ensayos era deficiente (21).

La revisión Cochrane posterior de Gilligan et al., más amplia y metodológicamente más robusta, incluyó 46 estudios y no encontró beneficios claros de los programas familiares sobre la prevalencia o la frecuencia del consumo de alcohol en jóvenes. El efecto sobre el volumen consumido fue muy pequeño y la certeza de la evidencia fue baja o muy baja(22). Los programas incluidos abordaban comunicación, dinámica familiar, establecimiento de reglas, manejo de riesgos, parentalidad positiva, habilidades sociales y autorregulación. Estos componentes pueden considerarse contenidos pertinentes para la educación familiar, pero no debe afirmarse que su aplicación reduzca de manera consistente el consumo adolescente (22).

Hurley et al. aportan una distinción importante, porque analizaron los cambios producidos en las prácticas y actitudes de los padres, y no solamente el consumo de los adolescentes. De 13 programas evaluados, 10 mostraron algún cambio favorable informado por los padres. Siete de nueve programas mejoraron las actitudes restrictivas frente al consumo de menores y cuatro de cinco mejoraron la comunicación entre padres e hijos. También se observaron efectos favorables sobre reglas específicas relacionadas con el alcohol. En contraste, ninguno de los programas que evaluó monitoreo parental encontró cambios claros. Además, 10 programas fueron clasificados como de calidad débil, tres como moderada y ninguno como fuerte (23).

Estos hallazgos respaldan que la educación en el hogar incluya la revisión explícita de mensajes y prácticas que pueden normalizar el consumo. Entre ellas se encuentran la aceptación del consumo en menores, el ofrecimiento de alcohol, la minimización de sus consecuencias, la ausencia de reglas y la comunicación ambigua respecto a lo que la familia considera seguro. No obstante, el cambio en actitudes o reglas parentales debe distinguirse del efecto sobre el consumo. La evidencia muestra que algunos programas logran modificar prácticas parentales, pero no demuestra de manera concluyente que estas modificaciones reduzcan por sí mismas el consumo juvenil.

La educación familiar tampoco debería consistir únicamente en advertencias generales. Los programas deben ayudar a relacionar el alcohol con situaciones concretas del hogar, identificar qué prácticas

facilitan su disponibilidad o aceptación y seleccionar comportamientos específicos que la familia tenga capacidad real de modificar. La información debe adecuarse a la edad, la cultura, la composición familiar y el nivel de riesgo.

- ***Estrategias relacionales para facilitar la reflexión y la toma de decisiones***

La entrevista motivacional aporta principios relacionales pertinentes para fortalecer la participación y la formulación de compromisos. Este enfoque busca explorar las razones personales para cambiar, resolver ambivalencias y aumentar la percepción de capacidad, mediante preguntas abiertas, afirmaciones, escucha reflexiva, empatía y respeto por la autonomía. Su hipótesis relacional propone que la calidad de la interacción, especialmente la empatía y el espíritu colaborativo, puede favorecer el cambio, mientras que la confrontación, la imposición de consejos y los juicios pueden aumentar la resistencia(44).

La revisión Cochrane de Schwenker et al., que incluyó 93 estudios con 22.776 participantes, encontró que la entrevista motivacional puede producir reducciones pequeñas del consumo frente a la ausencia de intervención y algunos beneficios frente a la valoración con retroalimentación. Sin embargo, mostró poca o ninguna diferencia frente a la atención habitual o a otras intervenciones activas. Tampoco se estableció un efecto claro sobre la disposición al cambio o la permanencia en tratamiento. La certeza de la evidencia osciló entre moderada y muy baja(44).

Por consiguiente, la entrevista motivacional puede orientar la forma en que el equipo conversa con la familia, pero no debe presentarse como una intervención familiar autónoma ni como garantía de que se cumplirán los compromisos. Su principal aporte consiste en favorecer una relación en la cual la familia pueda expresar preocupaciones, reconocer discrepancias entre sus prácticas y sus propósitos de cuidado, formular sus propias razones para cambiar y escoger alternativas viables.

En la práctica, la conversación debería evitar que el profesional imponga acuerdos previamente definidos. Resulta más coherente explorar qué daños preocupan a la familia, qué situaciones desea transformar, qué acciones considera posibles, quién participará y qué apoyos necesitará. Los compromisos formulados bajo presión, amenaza o culpabilización tienen menor probabilidad de representar decisiones familiares sostenibles(37).

- ***Participación familiar y construcción conjunta de compromisos***

La participación es un componente central de la agencia, pero su efectividad específica está poco evaluada. Hurley et al. encontraron que la participación de madres, padres, comunidades y otros actores en el diseño de los programas era limitada. La mayoría de las intervenciones había sido desarrollada sin procesos robustos de consulta, colaboración o empoderamiento de sus usuarios. La revisión plantea que involucrar a los actores desde el diseño podría mejorar la pertinencia, aceptación y sostenibilidad de los programas, pero no demuestra que esta participación reduzca directamente el consumo (23).

La revisión propone un continuo de participación que comprende informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar. Para el entorno hogar, este continuo puede traducirse en pasar de una educación unidireccional a una construcción conjunta del plan familiar. Informar y consultar permiten que la familia comprenda el riesgo y exprese sus percepciones; involucrar y colaborar implican definir conjuntamente los problemas prioritarios y las alternativas; empoderar supone reconocer su capacidad para escoger y ajustar las acciones, dentro de los límites de seguridad y protección(23).

A partir de esta evidencia, los compromisos familiares deberían ser específicos, observables, realistas y revisables. Deben identificar la práctica que se modificará, las personas responsables, los apoyos requeridos, las situaciones que pueden dificultar su cumplimiento y la manera de verificar avances. Asimismo, deben involucrar a todos los integrantes de la familia, y no solo a niños, niñas y adolescentes, y dejar claro para todos cómo se modificarán las prácticas de consumo de alcohol en el hogar. No obstante, estas características constituyen una aplicación razonada de los principios de planificación y participación, dado que los estudios incluidos no evaluaron un formato estandarizado de compromisos familiares ni compararon diferentes métodos para concertarlos(52).

La participación tampoco implica que todos los integrantes deban estar presentes en todas las conversaciones. Cuando exista violencia, coerción, miedo, relaciones de control o riesgo para niños y otras personas dependientes, la concertación conjunta puede ser inadecuada. En estas situaciones, la protección y la valoración individual deben preceder cualquier acuerdo familiar.

- ***Intervenciones integradas cuando quien consume tiene responsabilidades parentales***

La evidencia más sólida para fortalecer un entorno cuidador en familias donde una madre o un padre presenta consumo problemático proviene de McGovern et al. La revisión Cochrane incluyó 22 estudios con 2.274 participantes y encontró que las intervenciones psicosociales reducían modestamente la frecuencia del consumo parental de alcohol a los seis y doce meses. El principal hallazgo fue que las intervenciones que combinaban el abordaje del consumo con habilidades parentales y relaciones familiares presentaban mejores resultados que aquellas centradas exclusivamente en el consumo o exclusivamente en la parentalidad (8,45).

Las intervenciones integradas redujeron la frecuencia del consumo parental de alcohol a los seis meses, SMD −0,56, y a los doce meses, SMD −0,42. En contraste, las intervenciones centradas únicamente en las habilidades parentales no mostraron reducciones significativas, y tampoco lo hicieron de manera consistente las intervenciones dirigidas solamente al consumo. La certeza de los análisis por tipo de intervención fue baja, debido al reducido número de estudios y participantes, pero la dirección del hallazgo fue consistente con la necesidad de abordar simultáneamente el consumo y sus implicaciones para el cuidado(8,45).

Estos resultados indican que, cuando quien consume es la madre, el padre o la persona cuidadora, la agencia familiar no se fortalece únicamente enseñando pautas de crianza ni aconsejando reducir el alcohol. La intervención debe integrar, al menos, la valoración del consumo, el reconocimiento de sus efectos sobre las responsabilidades de cuidado, el desarrollo de habilidades de comunicación y solución de problemas, la organización de rutinas seguras, la identificación de apoyos alternativos y la vinculación con el tratamiento que corresponda(21,22).

Los análisis de McGovern et al. no mostraron reducción del consumo parental cuando los hijos participaban directamente en una o más sesiones, mientras que algunas intervenciones sin presencia de los hijos mostraron pequeños beneficios. Esta evidencia es de baja calidad y no permite recomendar la exclusión general de niños y adolescentes. Sí respalda que su participación no sea automática y que se valore según la edad, el objetivo de la sesión, la seguridad, la posible exposición a información inadecuada y el riesgo de asignarles responsabilidades sobre el consumo o la recuperación de sus padres.

La revisión de Aswathy et al. complementa estos hallazgos al mostrar que las terapias de pareja y familia pueden trabajar habilidades relacionales, comunicación, solución de problemas, participación en el tratamiento y apoyo a la abstinencia. En algunos ensayos se observaron mejores tasas de vinculación, finalización del tratamiento, mantenimiento de la abstinencia o funcionamiento familiar. Sin embargo, los resultados

variaron entre modelos y poblaciones, y buena parte de la evidencia correspondió a cannabis, drogas ilícitas o policonsumo, por lo que su transferencia al consumo de alcohol debe realizarse con cautela(48).

- ***Seguimiento y monitoreo de los compromisos***

La evidencia indica que el cambio familiar debe evaluarse a lo largo del tiempo. McGovern et al. observaron efectos sobre el consumo parental a los seis y doce meses, mientras que Aswathy et al. identificaron intervenciones con seguimientos de varios meses y recomendaron ampliar los estudios longitudinales (8). Gilligan et al. incluyeron seguimientos de hasta cuatro años, pero no encontraron efectos globales claros de los programas familiares sobre el consumo juvenil (22). Esto muestra que el seguimiento es necesario para conocer si los cambios se sostienen, aunque no garantiza su mantenimiento (8,45).

Los documentos no identifican una frecuencia óptima de seguimiento ni un instrumento validado para monitorear compromisos familiares en el hogar. No obstante, los desenlaces empleados permiten establecer dominios relevantes para revisar: cambios en el consumo, ocurrencia de episodios de riesgo, cumplimiento de responsabilidades de cuidado, aplicación de reglas acordadas, comunicación familiar, conflictos, acceso a servicios y necesidad de modificar el plan.

El seguimiento no debería limitarse a preguntar si el compromiso se cumplió. Debe examinar qué facilitó o impidió su implementación, si aparecieron nuevos riesgos, si la acción continúa siendo pertinente y si la familia necesita apoyos adicionales. Los incumplimientos no deben interpretarse automáticamente como falta de voluntad. Pueden estar relacionados con dependencia, síntomas mentales, violencia, precariedad económica, normas sociales, disponibilidad de alcohol, presión de pares o ausencia de servicios.

Las herramientas telefónicas o digitales podrían facilitar recordatorios y contactos entre visitas, especialmente ante dificultades para asistir a talleres. Hurley et al. señalan su posible utilidad para reducir barreras de tiempo y participación, pero la evidencia incluida sobre estas modalidades fue escasa. Por ello, deben entenderse como opciones de apoyo y no como sustitutos demostrados de la intervención familiar o del seguimiento profesional (23).

- ***Construcción de un entorno protector***

Ruiz Sepúlveda et al. identificaron asociaciones entre el entorno familiar y el consumo de alcohol u otras sustancias. Entre los factores de riesgo descritos se encuentran las actitudes familiares permisivas, el consumo de los adultos, la disciplina inconsistente o excesivamente rígida, la baja supervisión, la conflictividad, el abuso, la escasa expresión afectiva, la falta de claridad sobre las expectativas y la baja cohesión. Como factores protectores se describieron la comunicación, el vínculo afectivo, el apoyo, la integración familiar, las normas claras, el acompañamiento emocional y el modelamiento de conductas saludables (47).

Estos hallazgos son útiles para valorar el contexto y definir posibles objetivos del cuidado familiar, pero proceden principalmente de estudios observacionales y de una revisión cualitativa con limitaciones metodológicas. Por tanto, no demuestran que indicar a una familia que "mejore la cohesión", "aumente la supervisión" o "sea más comunicativa" produzca automáticamente una reducción del consumo.

Esta distinción es especialmente importante para el monitoreo parental. Aunque la supervisión aparece asociada con menor consumo en estudios observacionales, Hurley et al. no encontraron que los programas incluidos lograran modificarla. En cambio, existe evidencia, aunque de calidad limitada, de que algunos programas sí modifican actitudes parentales, comunicación específica sobre alcohol y reglas familiares. Estos últimos constituyen objetivos de intervención más directamente sustentados (23,47).

Un entorno protector tampoco depende exclusivamente de la dinámica interna de la familia. La accesibilidad del alcohol, su precio, las normas culturales, la publicidad, la presión de pares y las condiciones sociales pueden facilitar el consumo y limitar el cumplimiento de los acuerdos. La orientación familiar debe reconocer estos condicionantes para evitar responsabilizar a la familia por riesgos que requieren también respuestas comunitarias, institucionales y poblacionales.

Por último, la evidencia permite identificar como estrategias con mayor sustento las intervenciones que combinan educación específica sobre alcohol orientada a transformar las pautas, patrones y situaciones de consumo al interior de las familias, comunicación colaborativa, reglas claras, habilidades relacionales, reconocimiento de los daños asociados, abordaje directo del consumo y seguimiento. Cuando una madre, un padre o un cuidador presenta consumo problemático, los programas integrados que trabajan simultáneamente el consumo y las responsabilidades parentales parecen más prometedores que aquellos centrados en un solo componente. Cuando se trata de prevenir el consumo en adolescentes, algunos programas modifican actitudes, comunicación y reglas parentales, pero no existe evidencia clara de que

reduzcan de manera consistente la prevalencia o frecuencia del consumo juvenil.

La participación de la familia debe orientarse a reconocer problemas, transformar pautas y patrones de consumo, seleccionar prioridades, formular acciones alcanzables y revisar los resultados, pero la evidencia sobre cocreación y empoderamiento sigue siendo principalmente conceptual. La entrevista motivacional puede aportar una forma empática y no confrontativa de facilitar estas decisiones, aunque sus efectos son pequeños y no reemplaza una intervención integral.

El seguimiento debe verificar tanto la ejecución de los compromisos como su efecto sobre la seguridad, el consumo, el cuidado y las relaciones familiares. La ausencia de cumplimiento debe conducir a revisar barreras y nivel de riesgo, no a intensificar la culpabilización. Cuando existan dependencia, violencia, riesgo para terceros, comorbilidad mental o deterioro grave del cuidado, los acuerdos familiares deben complementarse o reemplazarse por la activación de servicios clínicos y rutas de protección.

En conclusión, la agencia de cuidado se fortalece cuando la familia dispone de información pertinente, participa de manera segura en las decisiones, desarrolla habilidades concretas, define responsabilidades realistas y cuenta con acompañamiento para revisar y ajustar el plan. No se fortalece mediante mensajes generales, imposición de compromisos, vigilancia coercitiva ni atribución exclusiva de responsabilidad a los integrantes del hogar.

9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje de los riesgos y daños en las familias con consumo de alcohol en alguno de sus miembros en el entorno hogar.

Las pautas de actuación aquí recomendadas se organizan como una respuesta escalonada que integra la identificación de riesgos y daños, la intervención breve, la protección de las personas expuestas, el fortalecimiento del cuidado familiar, la vinculación con servicios y el seguimiento. La familia debe reconocerse como sujeto colectivo de derechos y agente de cuidado, sin atribuirle la responsabilidad exclusiva de controlar el consumo ni de sustituir la atención profesional. Esta orientación es consistente con el Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol, el paquete SAFER y el Plan Integral de Cuidado Familiar, los cuales articulan la atención primaria, los servicios especializados, la protección,

la acción comunitaria y la intervención sobre los determinantes sociales y comerciales.

9.1 Pautas generales

- Promueva en la familia mensajes y prácticas coherentes frente al alcohol, fortaleciendo reglas claras, comunicación abierta y conductas de cuidado que puedan proyectarse hacia sus redes y entorno comunitario.
- Recuerde que fortalecer el cuidado dentro del hogar puede favorecer entornos más protectores, sin trasladar a la familia responsabilidades que corresponden también a la comunidad, las instituciones y el Estado.
- Recuerde que dejar el consumo puede requerir un acompañamiento para ayudar a organizar el sistema familiar para que funcione mejor a partir de estas nuevos acuerdos o pautas.
- En toda familia en la que se identifique consumo de alcohol, se recomienda valorar el riesgo desde una perspectiva individual, familiar y del entorno, explorando el patrón de consumo, los daños físicos y mentales, la afectación de las relaciones y responsabilidades de cuidado, la exposición de otras personas a riesgos, las condiciones sociales y territoriales, y los recursos con los que cuenta la familia para responder.
- Para comprender los riesgos y daños relacionados con el consumo de alcohol, considere de manera integrada las características del consumo, las condiciones de la persona y el contexto físico, familiar y social en que este ocurre. Explore no solo cuánto y con qué frecuencia se consume, sino también los motivos y circunstancias del consumo, quiénes están presentes, las normas y prácticas familiares, la disponibilidad de alcohol, las responsabilidades de cuidado y las condiciones del entorno que pueden aumentar o reducir los riesgos (Triada de Zinberg).

Dimensión	Qué explorar en el entorno familiar
Sustancia	Qué consume, cantidad y frecuencia, episodios intensos, mezclas con otras sustancias o medicamentos y consecuencias asociadas.
Persona	Motivos para beber, expectativas sobre el alcohol, estado emocional, salud física y mental, experiencias previas, capacidad de control, disposición al cambio y situaciones personales que aumentan el riesgo.
Contexto	Dónde, cuándo y con quién se consume; disponibilidad de alcohol en el hogar; celebraciones y rutinas; normas familiares; modelamiento de adultos; presencia de niños o personas dependientes; cuidado bajo efectos del alcohol; conflictos;

	presión social; movilidad y conducción; y características del entorno comunitario.

- Una indicación para la exploración en profundidad de los patrones de consumo es reconocer la pauta de relación en la familia y si este patrón de consumo está comportándose como síntoma dentro de la familia. Si el consumo Pauta en la familia en el sistema familiar. Y trabajar la pauta de otra forma.
- Antes de iniciar una intervención educativa o concertar compromisos, se recomienda establecer si existe una amenaza inmediata para la vida, la integridad, la seguridad o el cuidado de algún integrante. Si existe riesgo actual, se debe priorizar la atención de urgencias o la activación de rutas de protección sobre la intervención educativa o la concertación familiar.
- En toda conversación sobre alcohol se recomienda utilizar un lenguaje respetuoso, comprensible y no estigmatizante, evitar etiquetas, juicios morales, culpabilización o confrontación, y reconocer que el consumo y sus daños están condicionados por factores personales, familiares, sociales, culturales, económicos y comerciales.
- La participación de la familia se recomienda cuando sea voluntaria, pertinente y segura. Si existen violencia, coerción, miedo, relaciones de control, abuso o riesgo para niños, niñas, adolescentes u otras personas dependientes, no se recomienda realizar conversaciones o acuerdos conjuntos hasta que se hayan establecido medidas de protección.
- Las acciones familiares deben articularse con el nivel primario, los servicios de salud mental, la atención de urgencias, las rutas de protección, los servicios sociales y la oferta comunitaria. No se recomienda que la intervención concluya con la entrega de información o con una remisión sin acompañamiento.
- Los materiales educativos y los mensajes utilizados por los equipos deben estar basados en evidencia, proteger el interés de la salud pública y evitar contenidos que minimicen los riesgos o trasladen toda la responsabilidad a la persona y a su familia mediante expresiones ambiguas como «consumo responsable».
- Se debe recordar que no existe un nivel "seguro" de consumo de alcohol y que, por tanto, no deben promoverse orientaciones basadas en el «consumo responsable»; los mensajes deben señalar que la opción de menor riesgo es no consumir.
- Las orientaciones deben dirigirse, entre otros aspectos, al reconocimiento de los patrones de consumo de alcohol en la familia y de los daños presentes o potenciales, así como al

establecimiento de acuerdos familiares que permitan transformar los espacios y prácticas cotidianas de consumo.

- En las acciones de educación para la salud dirigidas a familias con riesgos o daños relacionados con el consumo de alcohol, se recomienda desarrollar procesos participativos y contextualizados, orientados a fortalecer capacidades de cuidado y no solo a brindar información. Incluya retroalimentación sobre riesgos, reflexión sobre prácticas cotidianas, comunicación no estigmatizante, definición conjunta de metas y estrategias de cambio, y seguimiento de los acuerdos, adaptando los contenidos al curso de vida, la composición familiar y el contexto territorial.

Se recomienda el siguiente flujo de acciones escalonadas:

1. Identificar el consumo, los daños, la severidad y la seguridad familiar.
2. Ofrecer una intervención breve cuando el riesgo pueda ser abordado desde el nivel primario.
3. Integrar el consumo con las responsabilidades parentales y de cuidado.
4. Utilizar herramientas educativas, relacionales y de planificación adaptadas a la familia.
5. Activar urgencias o protección cuando exista peligro para la persona o para terceros.
6. Gestionar atención de mayor intensidad ante dependencia, comorbilidad o falta de respuesta.
7. Concertar compromisos concretos, seguros y alcanzables.
8. Acompañar la remisión y verificar el acceso.
9. Realizar seguimiento y ajustar el plan.
10. Articular la respuesta familiar con las acciones comunitarias, territoriales y poblacionales.

9.2 Pautas pregunta 1. Valoración inicial

- ***Valoración y clasificación inicial***

• Si en la caracterización familiar, la historia clínica, la visita domiciliaria o el contacto con los servicios se identifica consumo de alcohol, se recomienda realizar una valoración estructurada que incluya, como mínimo, frecuencia y cantidad, episodios de consumo intenso, pérdida de control, tolerancia o abstinencia, daños físicos, mentales y sociales, afectación de las responsabilidades familiares, embarazo, consumo de otras sustancias, comorbilidades, disponibilidad de apoyo seguro y

barreras de acceso. Puede utilizarse una herramienta validada como AUDIT o AUDIT-C, pero el resultado debe interpretarse junto con la valoración clínica y familiar y no como único criterio para decidir la respuesta.

• Si la valoración identifica consumo de riesgo o perjudicial, sin signos de dependencia, abstinencia grave, daño clínico complejo o peligro para terceros, se recomienda ofrecer una intervención breve desde el nivel primario o durante la visita domiciliaria, realizada por un integrante del equipo con entrenamiento para ello.

- ***Intervención breve***

• Si se realiza una intervención breve, se recomienda incluir retroalimentación comprensible sobre el patrón de consumo, relación entre el alcohol y los riesgos o daños identificados, exploración de la disposición al cambio, consejo personalizado, selección de una meta, identificación de barreras y apoyos, definición de estrategias concretas y programación del seguimiento. No se recomienda limitar la intervención a entregar información general o recomendar "beber menos".

• Si la persona no reconoce el consumo como un problema o no está preparada para cambiarlo, se recomienda evitar la presión o la confrontación y orientar la conversación a aumentar la percepción del riesgo, explorar preocupaciones y mantener abierta la posibilidad de un contacto posterior. Si expresa ambivalencia, se recomienda analizar las ventajas y desventajas del cambio y fortalecer su confianza para dar un primer paso.

- ***Definición de la meta***

• Si la persona no alcanza inicialmente una meta de abstinencia y no presenta una condición en la que esta sea necesaria, se puede acordar una meta de reducción del consumo y de prevención de situaciones de alto riesgo. Se debe explicar que reducir el consumo puede disminuir algunos daños, pero no elimina completamente el riesgo y que, en términos de salud, menos consumo implica menor exposición.

• No se recomienda utilizar una meta de reducción como única respuesta durante el embarazo, ante dependencia o riesgo de abstinencia, cuando la persona debe conducir, manejar maquinaria o cuidar personas dependientes, ni cuando exista una enfermedad o tratamiento para el cual el consumo resulte inseguro. En estas situaciones se debe gestionar valoración clínica y definir una meta segura con el equipo tratante.

- ***Madres, padres y personas cuidadoras***

• Si quien consume alcohol tiene responsabilidades parentales o de cuidado, se recomienda una intervención integrada que aborde simultáneamente el consumo y sus implicaciones sobre el cuidado. Esta intervención debe explorar la supervisión y respuesta a las necesidades de las personas dependientes, el cuidado bajo los efectos del alcohol, la disponibilidad emocional, las rutinas familiares, la resolución de conflictos, la existencia de un cuidador alternativo seguro y las barreras para acceder al tratamiento.

• Si se identifica que una madre, un padre o una persona cuidadora consume durante los periodos en que debe proteger o supervisar a niños, personas mayores, personas con discapacidad u otros integrantes dependientes, se recomienda concertar de inmediato un plan de cuidado seguro, definir quién asumirá temporalmente la responsabilidad y valorar si procede activar una ruta de protección.

• No se recomienda que los hijos sean responsabilizados de vigilar, ocultar, retirar o controlar el alcohol, persuadir permanentemente al adulto para que cambie o garantizar su asistencia al tratamiento. Su participación debe definirse según la edad, el objetivo, su voluntad y su seguridad.

- ***Familias con adolescentes***

• Si en la familia hay niños o adolescentes, se recomienda trabajar con las personas adultas la comunicación específica sobre alcohol, la definición de reglas claras, el no suministro de bebidas alcohólicas, la no normalización del consumo en menores y el ejemplo que ofrecen los adultos. Se debe aclarar que estas acciones pueden mejorar algunas prácticas parentales, pero que la evidencia no demuestra de manera consistente que los programas familiares reduzcan por sí solos la prevalencia o frecuencia del consumo adolescente.

• Si el adolescente ya consume, presenta episodios intensos, se expone a accidentes, violencia u otras consecuencias, no se recomienda limitar la respuesta a una intervención universal de crianza. Se debe realizar una valoración individual y familiar, definir el nivel de riesgo y gestionar la intervención o remisión correspondiente.

- ***Embarazo***

• Si se identifica cualquier consumo de alcohol durante el embarazo, se recomienda ofrecer una intervención temprana orientada a la abstinencia, valorar cantidad, frecuencia, episodios intensos, pérdida de control, síntomas de abstinencia, consumo de otras sustancias, salud mental, violencia y barreras sociales, y articular la respuesta con la atención prenatal y los servicios de salud mental o consumo de sustancias.

• En familias con una gestante, se recomienda acordar que los integrantes no le ofrezcan alcohol, no la presionen para beber, no normalicen su consumo, favorezcan su asistencia a los controles y faciliten la búsqueda de ayuda cuando presente dificultades para suspenderlo.

- ***Herramientas digitales***

• Si la familia y la persona cuentan con conectividad, alfabetización digital y condiciones de privacidad, se pueden utilizar herramientas digitales para el autorregistro, la retroalimentación, la educación, los recordatorios, el seguimiento de metas y el contacto entre visitas. Estas herramientas deben vincularse con un profesional y no deben sustituir la valoración clínica, la intervención familiar o el tratamiento especializado.

• Antes de utilizar una herramienta digital se recomienda verificar que el instrumento o contenido sea válido, que la información sea comprensible, que los datos estén protegidos y que el dispositivo no sea utilizado por otro integrante para vigilar, castigar o controlar a la persona. Se recomienda reemplazar o complementar la herramienta digital con una valoración presencial cuando se identifique consumo de alto riesgo, signos de dependencia o abstinencia, comorbilidad mental, violencia o control coercitivo de las comunicaciones.

- ***Escalamiento y activación de rutas***

• Si se identifica dependencia, síntomas de abstinencia, pérdida persistente de control, daño orgánico, comorbilidad mental, consumo de varias sustancias, falta de respuesta a una intervención breve, deterioro grave del funcionamiento familiar o riesgo para terceros, se recomienda gestionar una valoración de mayor intensidad y articular la atención con salud mental, tratamiento del consumo de sustancias y otros servicios requeridos.

• Si se decide remitir, se recomienda explicar la razón, verificar la comprensión y aceptación de la persona, identificar barreras, facilitar el contacto con el servicio, registrar la gestión, confirmar posteriormente si la atención se produjo y revalorar el caso cuando la vinculación no se concrete. No se recomienda considerar cumplida la acción mediante la simple entrega de una orden, dirección o número telefónico.

• Para implementar estas intervenciones, se recomienda que las instituciones definan responsables, tiempos, protocolos, materiales, herramientas de registro, rutas de atención, mecanismos de supervisión y oportunidades de capacitación práctica. La capacitación aislada, sin recursos ni apoyo organizacional, no es suficiente para garantizar la implementación.

Consideración adicional: La evidencia que sustenta este paquete escalonado muestra un mayor respaldo para las intervenciones breves en adultos con consumo de riesgo, para las intervenciones integradas en madres y padres y para la atención articulada con el nivel primario. La evidencia directamente domiciliaria y dirigida a la familia como unidad sigue siendo limitada.

9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones

- ***Retroalimentación educativa***

• Si la familia no reconoce la relación entre el consumo y sus problemas cotidianos, se recomienda ofrecer retroalimentación personalizada, vinculando el patrón de consumo con situaciones concretas, como accidentes, conflictos, afectación del cuidado, gastos que desplazan necesidades básicas, ausencias laborales o escolares, incumplimiento de responsabilidades y exposición de terceros a riesgos.

• La información debe adaptarse a la edad, escolaridad, cultura, ruralidad, composición familiar y nivel de riesgo. No se recomienda utilizar exclusivamente mensajes generales sobre enfermedades futuras, materiales extensos o lenguaje técnico que no se relacione con las preocupaciones inmediatas de la familia.

• Si se utiliza comparación con el consumo de otras personas, se recomienda evitar mensajes que puedan normalizarlo, por ejemplo, señalar que el consumo es aceptable porque otras personas beben más. La retroalimentación debe centrarse en los riesgos y daños de la persona y su familia, no únicamente en normas poblacionales.

- ***Conversación estructurada***

• Para orientar la conversación se recomienda utilizar una estructura breve que incluya retroalimentación, reconocimiento de la responsabilidad y autonomía de la persona, consejo, presentación de alternativas, empatía, fortalecimiento de la autoeficacia, escucha, definición de metas y selección de estrategias, conforme a modelos como FRAMES o FLAGS, adaptados al contexto familiar.

La siguiente tabla presenta los componentes de los modelos referidos.

Modelo	Componente	Significado	Aspecto operativo en la orientación a la persona y la familia

FRAMES	F, Feedback	Retroalimentación	Comunicar de forma clara y personalizada los resultados de la valoración, el patrón de consumo identificado y su relación con daños o riesgos clínicos, familiares y sociales. Evitar mensajes generales o moralizantes.
FRAMES	R, Responsibility	Responsabilidad personal	Reconocer que la decisión de cambiar corresponde a la persona que consume. La familia puede acompañar y proteger, pero no debe asumir la responsabilidad de controlar el consumo o garantizar el cambio.
FRAMES	A, Advice	Consejo	Recomendar de manera directa, respetuosa y comprensible reducir o suspender el consumo, de acuerdo con el nivel de riesgo. Explicar las razones del consejo y las situaciones en las que se requiere abstinencia.
FRAMES	M, Menu of options	Menú de alternativas	Presentar varias opciones posibles de cambio y seleccionar conjuntamente las más viables, por ejemplo, disminuir la cantidad, evitar situaciones de consumo, no conducir, designar un cuidador sobrio, llevar un autorregistro o solicitar atención.
FRAMES	E, Empathy	Empatía	Escuchar de manera reflexiva, respetuosa y comprensiva, sin confrontar, juzgar ni culpabilizar. Explorar las preocupaciones de la persona y de la familia, preservando la autonomía y la seguridad.
FRAMES	S, Self-efficacy	Autoeficacia	Fortalecer la confianza de la persona y la familia en su capacidad para realizar cambios concretos. Reconocer logros previos, capacidades, apoyos disponibles y pequeños avances.
FLAGS	F, Feedback	Retroalimentación	Relacionar el consumo con los riesgos y daños identificados, utilizando información concreta y comprensible para la persona y la familia.
FLAGS	L, Listen	Escuchar	Permitir que la persona y la familia expresen sus preocupaciones, percepciones, ambivalencias, necesidades y barreras. Utilizar

			preguntas abiertas y escucha reflexiva.
FLAGS	A, Advice	Consejo	Ofrecer una recomendación profesional clara sobre reducción, abstinencia, protección frente a daños o necesidad de buscar atención, adaptada al nivel de riesgo.
FLAGS	G, Goals	Metas	Definir conjuntamente una meta específica, observable y alcanzable. La meta debe indicar qué se espera cambiar y en qué periodo, por ejemplo, no consumir durante responsabilidades de cuidado o acudir a una valoración.
FLAGS	S, Strategies	Estrategias	Acordar las acciones necesarias para alcanzar la meta, identificar situaciones desencadenantes, apoyos, obstáculos, responsables y alternativas ante dificultades o recaídas.

Fuente: elaboración propia

• Si la persona o la familia expresan resistencia, vergüenza, temor o ambivalencia, se recomienda utilizar preguntas abiertas, escucha reflexiva, reconocimiento de los esfuerzos y exploración de sus propias razones para cambiar. No se recomienda discutir, amenazar, avergonzar ni utilizar a otros familiares para presionar el cambio.

• La entrevista motivacional puede utilizarse como un estilo de comunicación para explorar ambivalencias y favorecer decisiones propias, pero no se recomienda presentarla como una herramienta autosuficiente ni asumir que garantiza el cambio o el cumplimiento de los compromisos.

- ***Identificación de prácticas cotidianas***

• Durante la visita se recomienda identificar junto con la familia las situaciones que facilitan o desencadenan el consumo, tales como disponibilidad permanente de bebidas en el hogar, ofrecimiento durante celebraciones, consumo antes o durante responsabilidades de cuidado, presión de familiares o pares, conflictos, malestar emocional, rutinas posteriores al trabajo, conducción, publicidad, promociones y fácil acceso territorial.

• Si se identifica una práctica modificable, se recomienda seleccionar inicialmente una o pocas acciones prioritarias, en lugar de formular una lista extensa de recomendaciones. La acción debe corresponder al riesgo más importante y a la capacidad real de la familia para modificarlo.

- ***Planificación del cambio***

• Si la persona o la familia están preparadas para actuar, se recomienda construir un plan que especifique qué práctica se modificará, quién realizará la acción, cuándo y con qué frecuencia, qué recursos necesita, qué obstáculos pueden aparecer y cómo se verificará el avance.

• Las herramientas de planificación pueden incluir autorregistros, calendarios, recordatorios, hojas de metas, mapas de situaciones desencadenantes, listas de alternativas, planes para solicitar ayuda y programadores de compromisos familiares. Estas herramientas deben ser sencillas, comprensibles y utilizables en la vida cotidiana.

• Si se utiliza un autorregistro, se recomienda incluir, según pertinencia, día y cantidad de consumo, circunstancias, personas presentes, estado emocional, consecuencias, cumplimiento de responsabilidades y estrategias utilizadas. No se recomienda que el registro sea controlado coercitivamente por otro integrante.

- ***Familias con adolescentes***

• Si existen adolescentes en el hogar, se recomienda utilizar conversaciones planificadas y apropiadas para la edad, expresar con claridad la posición familiar frente al consumo en menores, establecer reglas sobre no consumo y no suministro, preparar respuestas frente a presión de pares y acordar qué hacer ante una situación de riesgo.

• La supervisión, la cohesión y la comunicación deben valorarse como condiciones familiares relevantes, pero no se recomienda afirmar que indicarlas de manera general reduce el consumo. Deben traducirse en prácticas observables y apoyarse en intervenciones que hayan demostrado capacidad para modificar actitudes, reglas o comunicación.

- ***Herramientas digitales***

• Si se utilizan aplicaciones, páginas web, mensajes, llamadas automatizadas o autorregistros digitales, se recomienda seleccionarlos según validez, facilidad de uso, privacidad, accesibilidad y articulación con el seguimiento profesional. No se recomienda incorporar una plataforma únicamente por estar disponible o por afirmar que promueve el "consumo responsable".

9.4 Pautas pregunta 3. Canalización prioritaria

- ***Evaluación inmediata de la seguridad***

• Si durante la visita o el contacto se identifica consumo reciente, se recomienda verificar antes de continuar si existe peligro actual para la

persona o para terceros, lesión, accidente, conducta violenta, amenaza suicida, exposición de niños o personas dependientes a cuidado inseguro o síntomas compatibles con intoxicación o abstinencia. Se recomienda verificar también las condiciones del hogar que pueden aumentar el peligro, como el acceso a armas, herramientas peligrosas u otros medios letales, la disponibilidad de vehículos o el aislamiento geográfico, ya que pueden justificar escalar la atención aun cuando los síntomas clínicos parezcan leves.

Atención inmediata

• Si existe sospecha de intoxicación aguda o envenenamiento por alcohol, especialmente cuando se acompaña de lesión, accidente, caída, trauma o alteración importante del comportamiento o del estado de conciencia, se recomienda solicitar atención inmediata. No se recomienda mantener a la persona únicamente bajo observación familiar en el hogar.

• Si la persona presenta una convulsión después de reducir o suspender el consumo, se recomienda activar atención de urgencias por posible abstinencia grave. Si presenta temblor, insomnio, inquietud, náuseas, sudoración o aceleración del ritmo cardiaco, se recomienda valoración clínica prioritaria; si los síntomas progresan o aparece deterioro, se debe gestionar atención inmediata.

• Si existe consumo prolongado, tolerancia, antecedentes de abstinencia o sospecha de dependencia, no se recomienda indicar una suspensión brusca sin valoración profesional, debido al riesgo de complicaciones.

• Si la persona conduce, intenta conducir, manipula maquinaria, nada, se expone a caídas, participa en peleas, mantiene relaciones sexuales en condiciones inseguras o realiza otra actividad peligrosa bajo los efectos del alcohol, se recomienda interrumpir la exposición de manera segura y gestionar atención según el daño o peligro existente.

• Si se identifica ideación o conducta suicida, amenaza de muerte, preparación de medios para hacerse daño, violencia aguda, amenaza de daño a terceros o una combinación de intoxicación e ideación suicida, se recomienda activar de inmediato la atención en salud y las medidas de protección correspondientes.

Activación de rutas de protección

• Si el consumo se asocia con violencia física, sexual o psicológica, abuso, abandono, negligencia o exposición de niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad u otros integrantes dependientes a una situación insegura, se recomienda activar la ruta de protección y gestionar simultáneamente la atención en salud Se deben activar de

acuerdo con los protocolos y rutas del municipio los canales que posibiliten la seguridad de las personas del hogar.

• La activación de la ruta de protección no debe condicionarse a que quien consume reconozca el problema, acepte tratamiento o cumpla criterios diagnósticos de dependencia. El criterio principal es la existencia de una amenaza o daño para otra persona. Es importante reconocer y activar dispositivos comunitarios de protección.

• Si existe sospecha de violencia o control, se recomienda entrevistar de forma privada y separada a la persona posiblemente afectada y al posible agresor. No se recomienda promover una confrontación conjunta, retirar el alcohol por la fuerza ni pedir a la familia que controle físicamente a la persona.

Valoración prioritaria

• Si se identifica beber más o durante más tiempo de lo planeado, intentos fallidos de reducir el consumo, deseo intenso de beber, abandono de actividades, dedicación de gran parte del tiempo al consumo o recuperación, tolerancia, abstinencia, lagunas de memoria, lesiones recurrentes, persistencia pese a daños o deterioro familiar, laboral o escolar, se recomienda gestionar una valoración clínica prioritaria por posible trastorno por consumo de alcohol.

• Si se identifica consumo durante el embarazo, se recomienda una valoración prioritaria, independientemente de la cantidad informada. Si además existen sangrado, síntomas de aborto, parto pretérmino, desprendimiento placentario u otra complicación materno-perinatal, se debe solicitar atención urgente.

• Si la persona presenta depresión, ansiedad, trauma, otra alteración mental, consumo de otras sustancias, enfermedad que puede agravarse con el alcohol, polifarmacia o posibles interacciones medicamentosas, se recomienda valoración prioritaria para definir la meta y el manejo clínico seguro.

Seguimiento después de una urgencia

• Si la persona ha sido atendida por intoxicación, accidente, lesión, agresión o cualquier evento relacionado con alcohol, se recomienda que el alta sea seguida por valoración del patrón de consumo, intervención breve, revisión de la seguridad familiar, remisión cuando corresponda y seguimiento. No se recomienda cerrar el caso una vez resuelto el evento agudo.

• Si se repiten consultas por intoxicación, lesiones, accidentes, peleas u otros eventos relacionados con alcohol, se recomienda escalar la

intensidad de la valoración y revisar la necesidad de atención especializada y de medidas de protección.

• Los instrumentos de tamización y sus puntos de corte pueden apoyar la clasificación, pero no sustituyen la evaluación de la seguridad, los daños a terceros, la capacidad de cuidado y la severidad clínica. La evidencia no identificó una escala domiciliaria validada que determine por sí sola urgencia, protección o remisión. La familia puede apoyar el acceso a la atención, pero no debe asumir la vigilancia ni el control del consumo.

El seguimiento debe incluir una dimensión o mecanismo de comprobación de la efectividad en la canalización.

9.5 Pautas pregunta 4

- ***Reconocimiento de capacidades y límites familiares***

• Si se identifica consumo de alcohol o exposición familiar a sus daños, se recomienda valorar tanto las vulnerabilidades como las capacidades de la familia, incluyendo vínculos de apoyo, personas significativas, habilidades de comunicación, recursos comunitarios, experiencias previas de cambio y capacidad para solicitar ayuda.

• Se debe explicar que fortalecer la agencia de cuidado significa que la familia participa en las decisiones, moviliza sus recursos y adopta prácticas de protección, pero no significa que deba vigilar, tratar o controlar a la persona que consume ni asumir responsabilidades propias de los servicios de salud.

- ***Construcción del entorno protector***

• Si la familia desea construir un entorno protector, se recomienda revisar prácticas que pueden normalizar o facilitar el consumo, tales como ofrecer alcohol a menores o gestantes, mantener una disponibilidad permanente sin considerar los riesgos, celebrar el consumo excesivo, minimizar sus consecuencias, utilizar el alcohol como mecanismo habitual de afrontamiento, presentar mensajes contradictorios o permitir que una persona cuide o conduzca bajo sus efectos.

• Si se identifican actitudes familiares permisivas, consumo visible y frecuente de los adultos, reglas poco claras o comunicación ambigua, se recomienda seleccionar prácticas concretas para modificar. No se recomienda formular compromisos generales como "mejorar la comunicación", "ser más unidos" o "vigilar más", sin definir la acción que permitirá alcanzar ese propósito.

• La comunicación, el apoyo, la cohesión, la supervisión y el vínculo afectivo pueden considerarse factores potencialmente protectores, pero se debe diferenciar su asociación observacional con menor consumo de la evidencia de intervenciones que efectivamente han logrado modificarlos. No se recomienda afirmar que fortalecer un factor reduce el consumo si esta relación no ha sido demostrada mediante una intervención evaluada.

- ***Participación y concertación***

• Para fortalecer la participación familiar se recomienda avanzar de la información unidireccional hacia la consulta, el involucramiento, la colaboración y, cuando sea posible, la toma de decisiones compartida. La familia debe poder expresar qué riesgos le preocupan, cuáles considera prioritarios, qué prácticas desea cambiar y qué apoyos necesita.

• Si la familia está en condiciones de concertar un compromiso, se recomienda que este sea sencillo, específico, observable, realista y revisable. Debe contener una acción expresada mediante un verbo, la persona o personas responsables, la frecuencia, el plazo, los apoyos necesarios y la forma de verificar su cumplimiento.

• Los compromisos pueden incluir, según los riesgos identificados, no ofrecer alcohol a menores o gestantes, designar un cuidador sobrio, evitar conducir después de consumir, registrar el consumo, retirar el alcohol de espacios específicos cuando sea seguro, contactar un servicio, asistir a una valoración o establecer una regla familiar para situaciones sociales.

• No se recomienda imponer compromisos que la familia no comprenda o no considere viables. Tampoco se recomienda concertar acciones que expongan a un integrante a violencia, control, represalias o sobrecarga. Antes de concertar compromisos, se recomienda explorar conflictos, sentimientos de culpa, sobrecarga de cuidado e inversión de roles, en especial cuando niños o adolescentes asumen funciones propias de los adultos, y ajustar los acuerdos para que no generen daño, presión ni responsabilidades inapropiadas.

El PICF establece que los compromisos deben corresponder a acciones concretas, formuladas con frecuencia y tiempo definidos, y que su claridad favorece la adherencia y la evaluación posterior.

- ***Estrategias relacionales***

• Si la persona o la familia manifiestan ambivalencia, se recomienda utilizar una conversación basada en preguntas abiertas, escucha reflexiva, empatía, reconocimiento de capacidades y exploración de razones propias para cambiar. La entrevista motivacional puede orientar esta relación, pero debe integrarse con educación, planificación, intervención clínica y seguimiento.

• Si la familia se encuentra en una etapa inicial de cambio, se recomienda aumentar gradualmente la conciencia sobre los riesgos sin saturar de información. Si se encuentra preparada para actuar, se recomienda definir el plan y los apoyos. Si ya ha iniciado cambios, se recomienda reconocer los logros y anticipar dificultades. Si ocurre una recaída o incumplimiento, se recomienda revisar lo sucedido, evitar la desmoralización y formular nuevas alternativas.

- ***Madres, padres y personas cuidadoras***

• Si quien consume es madre, padre o cuidador, se recomienda que los compromisos integren acciones relacionadas con el consumo y con el cuidado, como garantizar supervisión segura, organizar rutinas, definir apoyos alternativos, fortalecer la comunicación, resolver problemas y vincularse con la atención. No se recomienda trabajar únicamente pautas de crianza ni únicamente reducción del consumo.

• La participación de niños o adolescentes en sesiones o acuerdos no debe ser automática. Se recomienda valorar su edad, capacidad de comprensión, voluntad, seguridad y el riesgo de que asuman responsabilidades sobre la recuperación del adulto. Cuando su participación no aporte al objetivo o pueda causar daño, se deben realizar intervenciones separadas.

- ***Seguimiento de compromisos***

• En cada visita de seguimiento se recomienda revisar, como mínimo, el cambio en el patrón de consumo, la ocurrencia de episodios de riesgo, el cumplimiento de responsabilidades de cuidado, las reglas acordadas, la comunicación y los conflictos, el acceso a servicios, los nuevos riesgos y las barreras para ejecutar el plan.

• El seguimiento no debe limitarse a marcar el compromiso como cumplido o incumplido. Se recomienda identificar qué facilitó o impidió su realización, si la acción sigue siendo pertinente, si debe modificarse y si la familia necesita apoyos adicionales.

• Si un compromiso no se cumple, se recomienda explorar dependencia, abstinencia, problemas de salud mental, violencia, precariedad económica, disponibilidad de alcohol, presión social, dificultades de transporte, ausencia de servicios y otras barreras. No se recomienda interpretar automáticamente el incumplimiento como desinterés o falta de voluntad.

• Si existen condiciones de privacidad y acceso, se pueden utilizar llamadas, mensajes o herramientas digitales para recordar compromisos, realizar contactos entre visitas y detectar tempranamente dificultades.

Estas herramientas deben complementar, no reemplazar, el acompañamiento profesional.

- ***Articulación con los determinantes sociales y comerciales***

• Si la familia identifica que la disponibilidad territorial, los establecimientos cercanos, la venta a menores, la publicidad, las promociones, la presión social o las condiciones económicas dificultan el cumplimiento de los acuerdos, se recomienda registrar estas barreras y gestionarlas mediante acciones comunitarias, sectoriales o intersectoriales. No se debe responsabilizar a la familia por modificar condiciones que exceden su capacidad de acción.

• Los hallazgos familiares recurrentes sobre disponibilidad, venta a menores, conducción bajo los efectos del alcohol, violencia o publicidad dirigida a jóvenes deben agregarse y utilizarse para orientar la planeación territorial, la educación comunitaria, la inspección y vigilancia y la articulación con las intervenciones poblacionales de SAFER.

10. Referencias

1. World Health Organization. Alcohol. Health Topics [Internet]. WHO; 2024 [cited 2026 Oct 15]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
2. World Health Organization. Alcohol and cancer. Key Facts [Internet]. WHO; 2025 [cited 2026 Oct 15]. Available from: https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/alcohol-and-cancer
3. Castillo-Carniglia A, Keyes KM, Hasin DS, Cerdá M. Psychiatric comorbidities in alcohol use disorder. Lancet Psychiatry. 2019 Dec;6(12):1068–80. doi:10.1016/S2215-0366(19)30222-6
4. World Health Organization. Alcohol consumption and sustainable development: fact sheet on Sustainable Development Goals (SDGs): health targets [Internet]. Geneva; 2020 Oct [cited 2026 Oct 15]. Available from: https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2020-2370-42125-58041
5. Sperkova K, Anderson P, Llopis EJ. Alcohol policy measures are an ignored catalyst for achievement of the sustainable development goals. PLoS One. 2022 May 4;17(5):e0267010. doi:10.1371/journal.pone.0267010

6. Carvalho BO, Stea TH, Coombes L, Haugland SH. Associations Between Parental Alcohol Use and Parenting Practices: A Systematic Review. Behavioral Sciences. 2026 Feb 7;16(2):236. doi:10.3390/bs16020236

7. Secretaria de Salud de Boyacá. Análisis de la situación de salud de la vigencia 2024. ASIS Boyacá 2024. Tunja; 2025.

8. McGovern R, Newham J, Addison M, Hickman M, Kaner E. The effectiveness of psychosocial interventions at reducing the frequency of alcohol and drug use in parents: findings of a Cochrane Review and meta-analyses. Addiction. John Wiley and Sons Inc; 2022. p. 2571–82. doi:10.1111/add.15846 PubMed PMID: 35188313.

9. Moyer VA. Primary Care Interventions to Prevent Child Maltreatment: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med [Internet]. 2013;(159):289–95. Available from: www.annals.org

10. Secretaria de Salud de Boyacá. Informe trimestral de indicadores SIBACOM. Tunja; 2025 Jul.

11. Organización Mundial de la Salud. AUDIT : the Alcohol Use Disorders Identification Test : guidelines for use in primary health care. 2001.

12. Kaner EF, Beyer FR, Muirhead C, Campbell F, Pienaar ED, Bertholet N, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018 Feb 24;2018(6). doi:10.1002/14651858.CD004148.pub4

13. Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial sobre el alcohol 2022-2030. 2024.

14. Organización Mundial de la Salud - Organización Panamericana de la salud. SAFER: El paquete técnico [Internet]. 2019. Available from: www.paho.org/permissions.

15. Organization WH. Implementing what works in alcohol policy Progress report on the SAFER initiative. 2026.

16. Organización Mundial de la Salud. Estrategias mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. World Health Organization; 2011.

17. Kaner EFS, Beyer FR, Muirhead C, Campbell F, Pienaar ED, Bertholet N, et al. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2018. doi:10.1002/14651858.CD004148.pub4 PubMed PMID: 29476653.

18. Platt L, Melendez-Torres GJ, Bradley J, Newbury-Birch D, Kaner E, Ashton C. How effective are brief interventions in reducing alcohol consumption: do the setting, practitioner group and content matter? Findings from a systematic review and metaregression analysis. Open. 2016;6:11473. doi:10.1136/bmjopen-2016

19. Joseph J, Basu D. Efficacy of Brief Interventions in Reducing Hazardous or Harmful Alcohol Use in Middle-Income Countries: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Alcohol and Alcoholism. Oxford University Press; 2016. p. 56–64. doi:10.1093/alcalc/agw054 PubMed PMID: 27567270.

20. Ghosh A, Singh P, Das N, Pandit PM, Das S, Sarkar S. Efficacy of brief intervention for harmful and hazardous alcohol use: a systematic review and meta-analysis of studies from low middle-income countries. Addiction. John Wiley and Sons Inc; 2022. p. 545–58. doi:10.1111/add.15613 PubMed PMID: 34159673.

21. Foxcroft DR, Tsertsvadze A. Universal family-based prevention programs for alcohol misuse in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011 Sep 7. doi:10.1002/14651858.cd009308

22. Gilligan C, Wolfenden L, Foxcroft DR, Williams AJ, Kingsland M, Hodder RK, et al. Family-based prevention programmes for alcohol use in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2019. doi:10.1002/14651858.CD012287.pub2 PubMed PMID: 30888061.

23. Hurley E, Dietrich T, Rundle-Thiele S. A systematic review of parent based programs to prevent or reduce alcohol consumption in adolescents. BMC Public Health. BioMed Central Ltd.; 2019. doi:10.1186/s12889-019-7733-x PubMed PMID: 31684909.

24. Donoghue K, Patton R, Phillips T, Deluca P, Drummond C. The effectiveness of electronic screening and brief intervention for reducing levels of alcohol consumption: A systematic review and meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research. JMIR Publications Inc.; 2014. doi:10.2196/jmir.3193 PubMed PMID: 24892426.

25. Dedert EA, McDuffie JR, Stein R, McNiel JM, Kosinski AS, Freiermuth CE, et al. Electronic interventions for alcohol misuse and alcohol use disorders: A systematic review. Annals of Internal Medicine. American College of Physicians; 2015. p. 205–14. doi:10.7326/M15-0285 PubMed PMID: 26237752.

26. Tansil KA, Esser MB, Sandhu P, Reynolds JA, Elder RW, Williamson RS, et al. Alcohol Electronic Screening and Brief Intervention: A

Community Guide Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine. Elsevier Inc.; 2016. p. 801–11. doi:10.1016/j.amepre.2016.04.013 PubMed PMID: 27745678.

27. Ramsey AT, Satterfield JM, Gerke DR, Proctor EK. Technology-based alcohol interventions in primary care: Systematic review. Journal of Medical Internet Research. JMIR Publications Inc.; 2019. doi:10.2196/10859 PubMed PMID: 30958270.

28. Charlet K, Heinz A. Harm reduction—a systematic review on effects of alcohol reduction on physical and mental symptoms. Addiction Biology. 2017 Sep 1;22(5):1119–59. doi:10.1111/adb.12414 PubMed PMID: 27353220.

29. Dionisi T, De Vita V, Sario G Di, Gasbarrini A, Addolorato G. Alcohol use: less is better. An umbrella systematic review of clinical interventions, policies, and dose–response health risks in adults. European Journal of Internal Medicine. Elsevier B.V.; 2026. doi:10.1016/j.ejim.2026.106837 PubMed PMID: 41887989.

30. Minozzi S ALSRUSTMSJAR. ——————————— Psychosocial and medication interventions to stop or reduce alcohol consumption during pregnancy (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. Art. No.: CD015042. Cochrane Database of Systematic Reviews ; 2024.

31. Curry SJ, Krist AH, Owens DK, Barry MJ, Caughey AB, Davidson KW, et al. Screening and Behavioral Counseling Interventions to Reduce Unhealthy Alcohol Use in Adolescents and Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA - Journal of the American Medical Association. 2018 Nov 13;320(18):1899–909. doi:10.1001/jama.2018.16789 PubMed PMID: 30422199.

32. Botwright S, Sutawong J, Kingkaew P, Anothaisintawee T, Dabak SV, Suwanpanich C, et al. Which interventions for alcohol use should be included in a universal healthcare benefit package? An umbrella review of targeted interventions to address harmful drinking and dependence. BMC Public Health. 2023 Dec 1;23(1). doi:10.1186/s12889-023-15152-6 PubMed PMID: 36823618.

33. Glass JE, Hamilton AM, Powell BJ, Perron BE, Brown RT, Ilgen MA. Specialty substance use disorder services following brief alcohol intervention: A meta-analysis of randomized controlled trials. Addiction. 2015. p. 1404–15. doi:10.1111/add.12950 PubMed PMID: 25913697.

34. Chan PS fong, Fang Y, Wong MC sang, Huang J, Wang Z, Yeoh EK. Using Consolidated Framework for Implementation Research to

investigate facilitators and barriers of implementing alcohol screening and brief intervention among primary care health professionals: a systematic review. Implementation Science. BioMed Central Ltd; 2021. doi:10.1186/s13012-021-01170-8 PubMed PMID: 34801041.

35. Derges J, Kidger J, Fox F, Campbell R, Kaner E, Hickman M. Alcohol screening and brief interventions for adults and young people in health and community-based settings: A qualitative systematic literature review. BMC Public Health. BioMed Central Ltd.; 2017. doi:10.1186/s12889-017-4476-4 PubMed PMID: 28599632.

36. Rosário F, Santos MI, Angus K, Pas L, Ribeiro C, Fitzgerald N. Factors influencing the implementation of screening and brief interventions for alcohol use in primary care practices: a systematic review using the COM-B system and Theoretical Domains Framework. Implementation Science. BioMed Central Ltd; 2021. doi:10.1186/s13012-020-01073-0 PubMed PMID: 33413487.

37. Blake H, Chaplin WJ, Gupta A, Coffey F. The effectiveness of digital training on screening, brief interventions, and referral to treatment (SBIRT) for medical and health professionals: a systematic review. British Medical Bulletin. Oxford University Press; 2025. doi:10.1093/bmb/ldaf013 PubMed PMID: 40982483.

38. Angus C, Latimer N, Preston L, Li J, Purshouse R. What are the implications for policy makers? A systematic review of the cost-effectiveness of screening and brief interventions for alcohol misuse in primary care. Front Psychiatry. 2014;5(AUG). doi:10.3389/fpsyt.2014.00114

39. Le LKD, Faller J, Chatterton M Lou, Perez JK, Chiotelis O, Tran HNQ, et al. Interventions to prevent alcohol use: systematic review of economic evaluations. BJPsych Open. 2023 Jul;9(4). doi:10.1192/bjo.2023.81

40. Zhang DX, Li STS, Lee QKY, Chan KHS, Kim JH, Yip BHK, et al. Systematic review of guidelines on managing patients with harmful use of alcohol in primary healthcare settings. Alcohol and Alcoholism. Oxford University Press; 2017. p. 595–609. doi:10.1093/alcalc/agx034 PubMed PMID: 28591801.

41. Rosembaun A, Rojas P, Rodriguez MV, Barticevic N, Rivera Mercado S. Intervenciones breves para promover cambios conductuales en el ámbito de la atención primaria: revisión de su efectividad en consumo de tabaco, alcohol y sedentarismo. Medwave. 2018 Jan

29;18(1):e7148. doi:10.5867/medwave.2018.01.7148 PubMed PMID: 29385118.

42. Stockings E, Hall WD, Lynskey M, Morley KI, Reavley N, Strang J, et al. Prevention, early intervention, harm reduction, and treatment of substance use in young people. The Lancet Psychiatry. Elsevier Ltd; 2016. p. 280–96. doi:10.1016/S2215-0366(16)00002-X PubMed PMID: 26905481.

43. Frost H, Campbell P, Maxwell M, O'Carroll RE, Dombrowski SU, Williams B, et al. Effectiveness of Motivational Interviewing on adult behaviour change in health and social care settings: A systematic review of reviews. PLoS ONE. Public Library of Science; 2018. doi:10.1371/journal.pone.0204890 PubMed PMID: 30335780.

44. Schwenker R, Dietrich CE, Hirpa S, Nothacker M, Smedslund G, Frese T, et al. Motivational interviewing for substance use reduction. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2023. doi:10.1002/14651858.CD008063.pub3 PubMed PMID: 38084817.

45. McGovern R, Newham JJ, Addison MT, Hickman M, Kaner EFS. Effectiveness of psychosocial interventions for reducing parental substance misuse. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021 Mar 16;2021(3). doi:10.1002/14651858.CD012823.pub2 PubMed PMID: 33723860.

46. O'Donnell A, Anderson P, Newbury-Birch D, Schulte B, Schmidt C, Reimer J, et al. The impact of brief alcohol interventions in primary healthcare: A systematic review of reviews. Alcohol and Alcoholism. 2014 Jan;49(1):66–78. doi:10.1093/alcalc/agt170 PubMed PMID: 24232177.

47. Sepúlveda Ruiz L, Rivera K, Rincón Y. Revisión sistemática de literatura: El entorno familiar y su relación con el consumo de sustancias. [Internet]. 2020 Jul [cited 2026 Aug 1]. Available from: https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/cd6a39b0-1c4c-416c-bc67-bb18768adc09/content

48. Aswathy P V., Junaid KP, Ghosh A, Basu D, Sharma SK, Pillai RR. Efficacy of Family-based Interventions in Addressing Substance Use Disorders: A Systematic Review on Randomized Controlled Trials. Indian Journal of Psychological Medicine. SAGE Publications Ltd; 2026. doi:10.1177/02537176261435440

49. Villanueva-Blasco VJ, Eslava D, Olave L, Torrens M. Electronic interventions in primary care to address substance use: A systematic

review. Addictive Behaviors. 2024 Sep;156:108073. doi:10.1016/j.addbeh.2024.108073

50. Tan CJ, Shufelt T, Behan E, Chantara J, Koomsri C, Gordon AJ, et al. Comparative effectiveness of psychosocial interventions in adults with harmful use of alcohol: a systematic review and network meta-analysis. Addiction. John Wiley and Sons Inc; 2023. p. 1414–29. doi:10.1111/add.16187 PubMed PMID: 36905310.

51. Kohler S, Hofmann A. Can motivational interviewing in emergency care reduce alcohol consumption in young people? A systematic review and meta-analysis. Alcohol and Alcoholism. 2015 Mar 1;50(2):107–17. doi:10.1093/alcalc/agu098 PubMed PMID: 25563299.

52. Secretaria de Salud de Boyacá. LINEAMIENTO TÉCNICO PICF 2025. 2025.

11. Anexos

11.1 Ecuaciones de búsqueda

Pregunta refinada	Estructura aplicable	Ecuación general para PubMed
P1. En familias con uno o más integrantes que presentan consumo de alcohol asociado con riesgos o daños, ¿qué intervenciones familiares, domiciliarias o articuladas con la atención primaria son efectivas y factibles para prevenir, reducir o manejar los daños individuales, familiares y del entorno?	PICO P: familias con uno o más integrantes que consumen alcohol y presentan riesgos o daños relacionados. I: intervenciones familiares, domiciliarias o articuladas con atención primaria. C: atención habitual, consejo mínimo, intervención individual u otra intervención. O: reducción de riesgos y daños, funcionamiento familiar, seguridad, vinculación con servicios, aceptabilidad y factibilidad.	("Alcohol-Related Disorders"[Mesh] OR "Alcohol Drinking"[Mesh] OR "Alcoholism"[Mesh] OR "Alcoholic Intoxication"[Mesh] OR "Binge Drinking"[Mesh] OR alcohol use disorder*[tiab] OR alcohol dependenc*[tiab] OR alcohol misuse[tiab] OR alcohol abuse[tiab] OR hazardous drinking[tiab] OR harmful drinking[tiab] OR risky drinking[tiab] OR heavy drinking[tiab] OR binge drinking[tiab] OR problem drinking[tiab] OR alcohol-related harm*[tiab]) AND ("Family"[Mesh] OR "Family Relations"[Mesh] OR "Family Support"[Mesh] OR famil*[tiab] OR household*[tiab] OR spouse*[tiab] OR partner*[tiab] OR couple*[tiab] OR parent*[tiab] OR caregiver*[tiab] OR significant other*[tiab] OR affected family member*[tiab]) AND ("Family Therapy"[Mesh] OR "Couples Therapy"[Mesh] OR "Motivational Interviewing"[Mesh] OR "Counseling"[Mesh] OR "Health Education"[Mesh] OR "Case Management"[Mesh] OR family intervention*[tiab] OR family-based intervention*[tiab] OR family-focused intervention*[tiab] OR family therap*[tiab] OR couples therap*[tiab] OR behavioral couples therap*[tiab] OR behavioural couples therap*[tiab] OR brief intervention*[tiab] OR brief advice[tiab] OR motivational

		interview*[tiab] OR psychoeducat*[tiab] OR harm reduction[tiab] OR safety plan*[tiab] OR relapse prevention[tiab] OR case management[tiab] OR care coordination[tiab] OR linkage to care[tiab] OR treatment engagement[tiab] OR referral*[tiab] OR follow-up[tiab]) AND ("Home Care Services"[Mesh] OR "Primary Health Care"[Mesh] OR "Community Health Services"[Mesh] OR home-based[tiab] OR home visit*[tiab] OR household-based[tiab] OR domiciliar*[tiab] OR primary care[tiab] OR community-based[tiab] OR family health team*[tiab] OR community health worker*[tiab])
P2. ¿Qué herramientas educativas, comunicativas, conductuales, participativas y de planificación pueden utilizarse en el entorno hogar para que las familias reconozcan y modifiquen prácticas cotidianas que incrementan los riesgos y daños relacionados con el consumo de alcohol?	PCC P: familias con uno o más integrantes que consumen alcohol. C – Concepto: herramientas educativas, comunicativas, conductuales y de planificación para transformar prácticas cotidianas. C – Contexto: entorno hogar, visita domiciliaria, atención primaria o seguimiento comunitario.	("Alcohol-Related Disorders"[Mesh] OR "Alcohol Drinking"[Mesh] OR "Alcoholism"[Mesh] OR alcohol use disorder*[tiab] OR alcohol dependenc*[tiab] OR alcohol misuse[tiab] OR hazardous drinking[tiab] OR harmful drinking[tiab] OR risky drinking[tiab] OR binge drinking[tiab] OR problem drinking[tiab] OR alcohol-related harm*[tiab]) AND ("Family"[Mesh] OR "Family Relations"[Mesh] OR "Family Support"[Mesh] OR famil*[tiab] OR household*[tiab] OR spouse*[tiab] OR partner*[tiab] OR parent*[tiab] OR caregiver*[tiab]) AND ("Patient Education as Topic"[Mesh] OR "Health Education"[Mesh] OR "Consumer Health Information"[Mesh] OR "Health Promotion"[Mesh] OR "Motivational Interviewing"[Mesh] OR "Counseling"[Mesh] OR educational tool*[tiab] OR educational material*[tiab] OR educational intervention*[tiab] OR psychoeducat*[tiab] OR counsel*[tiab] OR motivational interview*[tiab] OR behavior change[tiab] OR behaviour change[tiab] OR goal setting[tiab] OR self-

		monitor*[tiab] OR action plan*[tiab] OR safety plan*[tiab] OR family agreement*[tiab] OR family contract*[tiab] OR communication skill*[tiab] OR problem solving[tiab] OR coping skill*[tiab] OR decision aid*[tiab] OR drinking diary[tiab] OR daily practice*[tiab] OR household practice*[tiab] OR drinking routine*[tiab] OR alcohol availability[tiab]) AND ("Home Care Services"[Mesh] OR "Primary Health Care"[Mesh] OR home-based[tiab] OR home visit*[tiab] OR household-based[tiab] OR domiciliar*[tiab] OR primary care[tiab] OR community-based[tiab])
P3. ¿Qué signos, síntomas, comportamientos, situaciones familiares y condiciones del entorno asociados con el consumo de alcohol indican la necesidad de solicitar atención inmediata, activar rutas de urgencias o protección, o gestionar una valoración prioritaria?	PCC P: personas que consumen alcohol y sus familias, especialmente integrantes dependientes o en condición de vulnerabilidad. C – Concepto: signos de alarma, condiciones de peligro y criterios de urgencia, protección o valoración prioritaria. C – Contexto: entorno hogar y decisiones familiares de búsqueda de ayuda.	("Alcohol-Related Disorders"[Mesh] OR "Alcohol Drinking"[Mesh] OR "Alcoholism"[Mesh] OR "Alcoholic Intoxication"[Mesh] OR "Binge Drinking"[Mesh] OR alcohol use disorder*[tiab] OR alcohol dependenc*[tiab] OR alcohol misuse[tiab] OR hazardous drinking[tiab] OR harmful drinking[tiab] OR binge drinking[tiab] OR alcohol intoxication[tiab] OR alcohol withdrawal[tiab]) AND ("Risk Assessment"[Mesh] OR "Alcoholic Intoxication"[Mesh] OR "Substance Withdrawal Syndrome"[Mesh] OR "Alcohol Withdrawal Delirium"[Mesh] OR "Emergencies"[Mesh] OR "Domestic Violence"[Mesh] OR "Intimate Partner Violence"[Mesh] OR "Suicidal Ideation"[Mesh] OR "Suicide"[Mesh] OR "Self-Injurious Behavior"[Mesh] OR "Accidents"[Mesh] OR warning sign*[tiab] OR warning symptom*[tiab] OR red flag*[tiab] OR danger sign*[tiab] OR alarm sign*[tiab] OR sign* of severity[tiab] OR severe intoxication[tiab] OR loss of consciousness[tiab] OR altered consciousness[tiab] OR

		confusion[tiab] OR seizure*[tiab] OR delirium tremens[tiab] OR severe withdrawal[tiab] OR suicid*[tiab] OR self-harm[tiab] OR violen*[tiab] OR aggression[tiab] OR child neglect[tiab] OR elder neglect[tiab] OR impaired caregiving[tiab] OR unsafe caregiving[tiab] OR injury[tiab] OR accident*[tiab] OR urgent referral[tiab] OR emergency referral[tiab] OR emergency care[tiab] OR help-seeking[tiab] OR seek help[tiab]) AND ("Family"[Mesh] OR "Caregivers"[Mesh] OR famil*[tiab] OR household*[tiab] OR caregiver*[tiab] OR spouse*[tiab] OR partner*[tiab] OR parent*[tiab] OR home[tiab] OR household[tiab] OR family response[tiab] OR family recognition[tiab])
P4.¿Qué estrategias educativas, participativas, relacionales y de seguimiento fortalecen la agencia de cuidado de las familias para construir y sostener un entorno protector que no normalice ni facilite el consumo de alcohol, reduzca la exposición a sus riesgos y daños, favorezca prácticas cotidianas de cuidado y permita definir, implementar y monitorear compromisos familiares?	PCC P: familias afectadas por el consumo de alcohol de uno o más integrantes. C – Concepto: estrategias para fortalecer agencia, autoeficacia, participación, toma compartida de decisiones y sostenimiento de compromisos; barreras y facilitadores sociales y comerciales. C – Contexto: entorno hogar, atención primaria, seguimiento familiar, comunidad y territorio.	("Alcohol-Related Disorders"[Mesh] OR "Alcohol Drinking"[Mesh] OR "Alcoholism"[Mesh] OR alcohol use disorder*[tiab] OR alcohol dependenc*[tiab] OR alcohol misuse[tiab] OR hazardous drinking[tiab] OR harmful drinking[tiab] OR risky drinking[tiab] OR problem drinking[tiab] OR alcohol-related harm*[tiab]) AND ("Family"[Mesh] OR "Family Relations"[Mesh] OR "Family Support"[Mesh] OR famil*[tiab] OR household*[tiab] OR spouse*[tiab] OR partner*[tiab] OR parent*[tiab] OR caregiver*[tiab]) AND ("Patient Participation"[Mesh] OR "Self Efficacy"[Mesh] OR "Decision Making, Shared"[Mesh] OR "Social Support"[Mesh] OR "Health Promotion"[Mesh] OR "Social Determinants of Health"[Mesh] OR empower*[tiab] OR family agency[tiab] OR care agency[tiab] OR family capacity[tiab] OR family capabilities[tiab] OR self-efficacy[tiab] OR shared decision*[tiab] OR family participation[tiab] OR family

		engagement[tiab] OR family involvement[tiab] OR goal setting[tiab] OR action plan*[tiab] OR care plan*[tiab] OR family commitment*[tiab] OR family agreement*[tiab] OR behavioral contract*[tiab] OR behavioural contract*[tiab] OR coping[tiab] OR resilience[tiab] OR family strength*[tiab] OR protective factor*[tiab] OR barrier*[tiab] OR facilitator*[tiab] OR sustain*[tiab] OR adherence[tiab] OR social determinant*[tiab] OR commercial determinant*[tiab] OR social norm*[tiab] OR cultural norm*[tiab] OR alcohol availability[tiab] OR alcohol accessibility[tiab] OR alcohol affordability[tiab] OR alcohol marketing[tiab] OR alcohol advertising[tiab]) AND ("Home Care Services"[Mesh] OR "Primary Health Care"[Mesh] OR "Community Health Services"[Mesh] OR home-based[tiab] OR home visit*[tiab] OR domiciliar*[tiab] OR primary care[tiab] OR community-based[tiab] OR rural[tiab] OR territorial[tiab])